

►► Niños de 2 años

El “bebé” de 2 años se está transformando en un niño pequeño. En realidad, se halla en el límite entre el bebé y el niño.

Ahora, dedica gran parte del día a lograr su independencia y autonomía, pero todavía se esconde frecuentemente detrás de las piernas de sus padres cuando está expuesto a extraños. Su motricidad ha progresado mucho.

La evaluación del lenguaje es fundamental durante esta consulta.

Es importante que los adultos entiendan que la resistencia de los niños de esta edad a aceptar órdenes no sólo está determinada por el hecho de desafiar la puesta de límites, sino también por la curiosidad que los caracteriza.

Desafían el “no” en un intento por lograr mayor autonomía y su mayor característica es la oposición. Requieren supervisión constante, ya que se aventuran más allá de sus capacidades y pueden exponerse a situaciones de peligro. Buscan constantemente los límites aceptables de sus conductas. Aún siguen teniendo dificultades para poder elegir y tolerar las frustraciones, por lo que los berrinches continúan siendo frecuentes. Sus deseos suelen ser imperativos y es posible que expresen actitudes agresivas hacia sus familiares.

Los padres tienen la responsabilidad de asumir una actitud de liderazgo y enseñarles cuáles son los límites, al mismo tiempo que deben adoptar las conductas adecuadas para estimular su autoestima e independencia.

Se trata de una etapa de aprendizaje mutuo, padres aprendiendo a educar y a poner límites, y niños comprendiendo su espacio y defendiendo sus deseos.

Se transita una etapa impregnada por el control de esfínteres (ver Anexo).

Los niños de esta edad se interesan por la conformación física de su cuerpo y las diferencias sexuales, y presentan conductas de autoexploración.

Motrizmente, el niño corre sin caerse, sube y baja escaleras solo, avanzando con los dos pies en cada escalón. Salta de un desnivel sin ayuda, adelantando primero un pie al otro.

Hace torres de 6 cubos con concepto de verticalidad y coloca cubos en línea como expresión del concepto de horizontalidad. Pasa hojas de un libro una a una. Se reconoce en el espejo.

Imita el dibujo vertical, no el horizontal. Hace garabatos espontáneamente.

El progreso del lenguaje es significativo, habla solo (soliloquio) mientras actúa y hace lo que dice. Va desapareciendo progresivamente la jerga, adquiere el mío, mí, vos y yo aproximadamente en ese orden. Prefiere llamarse por su propio nombre ("Felipe tira la pelota"). Emplea solo el presente. Conoce el nombre de algunos colores. Emplea palabras aisladas o en frases de tres o cuatro, como oraciones, pero no piensa ni habla en párrafos.

Sus contactos con otros niños son breves y se limitan, preferentemente, a juegos solitarios o paralelos. Tiene dificultades con otros por el "mío".

Dramatiza las relaciones familiares con muñecos. Ayuda a vestirse y desvestirse.

Mantiene la cuchara correctamente mientras la lleva a la boca.

Muchos niños concurren al jardín maternal y deberán analizarse con los padres las situaciones que se presenten: adaptación, cambios de conducta, seguridad, afectividad, advertencia de enfermedades epidémicas, vacunaciones.

Se está produciendo un cambio en la forma de resolver los problemas: primero piensa y luego actúa.

► ENTREVISTA

Los niños de esta edad, generalmente, se inhiben al entrar al consultorio y permanecen en brazos de sus padres. No suelen ofrecer la gran resistencia característica de los 18 meses. Algunos más independientes conversan con el médico e investigan el entorno. Otros continúan con una actitud opositora, que dificulta la interacción con el pediatra. Continúan siendo desconfiados y pueden, repentinamente, resistirse a la realización del examen físico. Tal vez sea mejor darles la opción de comenzar el examen en los brazos de los padres, si lo prefieren. Empezar con las maniobras menos molestas permite ganarse su confianza.

Observar el comportamiento del niño durante la consulta. Prestar atención a la forma en que se manejan los límites y cómo reacciona el niño frente a ellos. Evaluar las conductas y el lenguaje del niño al interactuar con él.

Examen físico y del crecimiento

Peso, longitud corporal y perímetro cefálico. Peso/talla. Índice de masa corporal. (Tablas OMS)

La talla alcanzada a los 2 años suele ser cercana a la mitad de la talla final adulta y hasta los 4 años crece aproximadamente 7-8 cm anuales. Determinar percentilos y relacionarlos con los de los padres.

A los 24 meses, el 97% de los niños tiene la fontanela anterior cerrada.

Evaluar subjetivamente la audición y la visión.

Para esta edad, en general, se ha corregido el genu varo fisiológico y el aspecto de las almohadillas plantares induce un pie plano inexistente.

Prestar especial atención a la detección de:

- ♦ Alteraciones de la marcha.
- ♦ Alineación del tronco, miembros inferiores y pies.
- ♦ Presencia de caries.
- ♦ Estrabismo.
- ♦ Masas abdominales.
- ♦ Pulsos femorales.
- ♦ Hernias.
- ♦ Fimosis.
- ♦ Testículos no descendidos.
- ♦ Signos de negligencia o maltrato.
- ♦ Palidez de piel y mucosas.

Desarrollo y conductas habituales

Motor grueso:

- ♦ Corre bien.
- ♦ Puede subir y bajar escaleras sin alternar los pies, con ayuda.
- ♦ Tira la pelota al observador (casi 90%). Recoge objetos del suelo sin caerse.
- ♦ Trepa por los muebles. Más del 25% salta en dos pies.

Motor fino:

- ♦ Utiliza cuchara y tenedor.
- ♦ Imita el trazo vertical y hace garabatos.
- ♦ Forma torres de 6 cubos, construye un tren con 4 cubos
- ♦ Abre las puertas; da vueltas las hojas de un libro una a una.
- ♦ Sostiene una taza con seguridad, incluso con una mano.

Lenguaje:

- ♦ Cumple órdenes de dos pasos.
- ♦ Tiene un vocabulario de aproximadamente 50 palabras.
- ♦ Forma frases de tres palabras, con sustantivo y verbo (75%); utiliza pronombres, a veces inadecuadamente; presta atención cuando le cuentan cuentos cortos.
- ♦ Empieza a decir su nombre completo.
- ♦ Dice "yo", tocando su cuerpo. Dice "mí" y "mío". Dice su edad.
- ♦ Habla mientras juega solo.
- ♦ Entiende las referencias arriba-abajo. Un observador externo a la familia entiende el 50% de lo que dicen.

Socio-adaptativo:

- ♦ Juega en paralelo con otros niños.
- ♦ Juego simbólico dirigido hacia un muñeco (da de comer a la muñeca).
- ♦ Se viste con ayuda, cepilla sus dientes con ayuda.
- ♦ Recuerda dónde se escondieron los objetos. Recuerda a menudo las experiencias inmediatas.
- ♦ Comienza el control de esfínteres.

Evaluación del desarrollo

- ♦ En el control de salud de los 2 años es muy importante la evaluación del lenguaje.
- ♦ A esta edad, combina dos palabras. Esto debe controlarse específicamente y plantea una señal de alerta cuando no está presente. El niño ya presenta un lenguaje inteligible para su entorno. Además, es capaz de cumplir órdenes de dos pasos.
- ♦ Prestar atención si no se relaciona de manera adecuada (ver *Supervisión niños de 10-11 meses*).

►► RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Alimentación

Ídem control de salud de los 18 meses.

Preguntar en detalle sobre los aportes de alimentos, tanto de leche como complementarios, pues en este período existen más riesgos de malnutrición.

Si aún es amamantado, comenzar el destete paulatinamente.

Evitar las llamadas comidas chatarra (salchichas, embutidos, hamburguesas, copetín, gaseosas, jugos industriales y golosinas), que no aportan nutrientes y contienen cantidades importantes de azúcar, grasas, conservantes, sal y colorantes (ver *Comidas obesogénicas*).

Mantener un horario de comidas. Continuar con la administración del suplemento de flúor si está indicado. Ofrecer suplementos vitamínicos si la dieta es muy restringida.

Ofrecer aproximadamente 500 ml de leche por día durante este año (ver *Anexos*).

Recomendar que, en la hora de las comidas, no debe estar encendido el televisor.

Vitaminas y oligoelementos

Sulfato ferroso: se indica en niños con déficit de hierro (ver *Anemia*).

Vitamina C: no se requiere cuando existe un adecuado aporte de frutas y verduras.

Vitamina D: alcanza con la exposición cotidiana al sol, salvo en regiones geográficas donde sea baja y lo requieran.

Flúor: solo en niños de zonas donde el agua no tenga la concentración adecuada y con situaciones especiales (ver *Salud bucal* y *Visita de los seis meses*).

Salud bucal

Ídem control de salud de los 15 meses (ver *Anexos*).

Los padres deberán educar a sus niños al lavado de dientes 2 veces al día con dentífricos adecuados en la concentración de flúor. Control odontológico para realizar aplicaciones de flúor y lacas.

Control de esfínteres

Algunos niños pueden comenzar con el entrenamiento del control de esfínteres desde los 18 meses, pero la mayoría comienza a partir de los 2 años; el proceso de aprendizaje de continencia fecal y de orina diurna es de aproximadamente seis meses. La incontinencia de orina nocturna (enuresis) no se considera como una alteración hasta pasados los 5 años.

Retrasar el entrenamiento hasta que el niño muestre signos de estar preparado: ritmo evacuatorio regular y previsible, pañales secos por lo menos durante 2 h, molestia manifiesta al tener el pañal sucio con materia fecal, interés en aprender a controlar esfínteres y capacidad para comunicar mediante palabras o expresiones faciales la inminencia de una micción o deposición. Estimular el aprendizaje de tolerancia a las frustraciones, lo cual disminuye las conductas opositoras y la resistencia del niño para controlar esfínteres.

No dejar pasar el tiempo y debieran existir pautas y actitudes claras por parte de los padres. Ver *Control de salud de los 18 meses* (ver Anexos).

Introducir la pelela como elemento casero, para que se familiarice y pueda jugar con ella, inclusive en el trasvasamiento del agua. Es conveniente el empleo de adaptadores de inodoro para que puedan apoyar adecuadamente los pies. Durante este período, es normal que puedan presentar micciones frecuentes y constipación (retención).

Sueño

A partir de los 2 años, ya no suelen requerir la siesta matinal y duermen en promedio 13 h. La necesidad de sueño varía mucho de un niño a otro. Verlo jugar activamente y sin somnolencia ni irritabilidad, es la mejor prueba de que descansa lo suficiente.

Recomendar una rutina al momento de acostarse: horario, cepillado de dientes, lectura de cuentos. Recordar que, duerma o no la siesta, debería dormir durante toda la noche.

Comentar a los padres el manejo adecuado de los despertares, terrores nocturnos y pesadillas. (Ver Anexos *El dormir: consejos para padres y Trastorno del sueño*).

Hábitos y conducta

Estimular el lenguaje correcto mediante conversaciones, canciones y la lectura de libros.

Cuando sea posible, hacerlo participar de las elecciones, para estimular su independencia y autonomía. Enseñar a compartir pero no esperar que lo haga.

Enseñar al niño normas de seguridad dentro de la casa y fuera de ella.

Limitar el uso del televisor a menos de una hora diaria, supervisando la programación.

Demostrar al niño afecto. Estimular el contacto físico. Ser estimulante y no desvalorizarlo. Enseñar con el ejemplo.

Intentar ser conciliador en las discusiones entre hermanos, no permitir la agresión.

Impedir que alcance las cosas más preciadas de su hermano mayor.

Educación: los límites comienzan en casa

Reconocer la buena conducta con palabras y demostraciones de afecto. No reaccionar negativamente a los reiterados "no" del niño y mantener la calma. Decidir en qué situaciones se pondrá límites y ser consistentes al aplicarlos.

Recordar: uno puede poner límites y demostrar afecto al mismo tiempo. No dar alternativas en aquellas situaciones que se considere prioritarias, mantener el "no" rotundo.

Enseñar a su hijo las conductas adecuadas cuando éste se encuentre tranquilo.

Corregir las conductas no deseadas con frases simples, sin demasiadas explicaciones.

No agredir físicamente. Ofrecer opciones alternativas cuando se le diga que "no" a algo.

Si es necesario, utilizar el método del aislamiento (alrededor de 2 minutos a esta edad), instruya a su hijo acerca de este método disciplinario cuando se encuentre tranquilo. Explique brevemente por qué ha sido disciplinado (ver Anexos).

No permitir que use el llanto como método de persuasión.

Corregir enérgicamente conductas agresivas, como pegar o morder. Los padres deben de-

mostrar consistencia y liderazgo. Felicitarlo cuando deje de hacer algo incorrecto. Estimular la independencia haciendo cumplir los límites

Juegos y juguetes

A los 2 años el niño juega solo, aún es incapaz de compartir sus juguetes o su juego. Disfruta de correr, saltar, jugar con agua, tierra o arena, tapar y destapar cajas.

Recién al final del segundo año, los niños empiezan a jugar juntos. Todavía no saben compartir. Se concentran en saber lo que es suyo y lo que pueden hacer con ello.

El niño de esta edad se interesa en los recipientes para transvasar sustancias de un recipiente a otro. Esto indica que comienza a aprender el control de sus esfínteres.

Ofrecer jugar con elementos que simbolicen esta etapa del control (contener y expulsar), como el agua, la masa y el barro.

No reprimirlo cuando se ensucia.

Acompañar al niño durante este aprendizaje que, a veces, puede causar miedo, fantasías e inquietudes.

Mediante los dibujos, comienza a retener imágenes de los otros y de sí mismo. Desde el mundo del propio cuerpo se traslada al mundo del juguete que esta fuera de él. Los juguetes complicados no son una buena opción. Deben ser juguetes sencillos que le permitan desarrollar su imaginación y sus posibilidades motrices. Los dos sexos pueden jugar a cuidar y a alimentar. Es importante que los padres no tengan prejuicios acerca de ello (ver Anexos).

Educación sexual

La educación sexual debe ser instruida en el seno familiar. Asesorar a los padres sobre la curiosidad normal por los genitales. Recomendar utilizar términos socialmente correctos para su denominación. Aconsejar la enseñanza de que los genitales no se tocan en público y comenzar a instruir sobre pautas de intimidad y cuidado (ver Anexos).

Prevención de accidentes

Ver control de salud de los 21 meses de edad.

Recordar que es de alto riesgo transportar niños en bicicletas, ciclomotores, motos, triciclos o cuatriciclos, aun con casco (ver Anexos).

Relaciones familiares y sociales

Continuar con las mismas recomendaciones que los meses previos (ver Anexos).

Vacunación

Verificar, en el carnet de vacunación, que tenga las vacunas al día (ver Anexos).

» PROBLEMAS DETECTADOS Y ESTRATEGIAS

Comentar los problemas detectados y plantear las estrategias para solucionarlos.

» CIERRE DE LA VISITA

Interrogar acerca de dudas que hayan quedado o preguntas pendientes.

Establecer la fecha de la próxima consulta a los 2 años y medio o 30 meses.

Establecer la conducta por seguir en caso de interurrencias, accidentes y emergencias.

►► Niños de 30 meses

En los últimos seis meses, el niño ha ido sustituyendo gradualmente la impulsividad por el razonamiento y está comenzando a controlar sus emociones.

A esta edad, los niños aún despliegan una energía considerable, que perdurará hasta comenzar la edad escolar. Debido a esto, muchos padres consideran que sus hijos son hiperactivos. Importa recalcar que es totalmente esperable que disfruten mucho más de correr, saltar o trepar que de permanecer sentados o caminar a paso tranquilo. Incluso, por este exceso de energía, pueden llegar a hablar tan rápido que presentan una característica disfluidez transitoria del lenguaje, típica de la edad.

Es aconsejable que los padres asuman esta realidad y adapten sus expectativas con respecto al grado de actividad de sus hijos. Sin embargo, es importante establecer límites claros, porque este exceso de energía puede conducir a conductas agresivas o disruptivas, si no se canaliza adecuadamente.

MOTOR GRUESO	LENGUAJE	MOTOR FINO	PERSONAL SOCIAL
SOSTEN LEVANTA	COPIA LETRA	MANOS SEPARADAS SEGURIDAD	CONTIENE EL JUEGO CONVIVE

» ENTREVISTA

Los niños de esta edad, generalmente, se inhiben al entrar al consultorio y permanecen cerca de sus padres. Algunos más independientes conversan con el médico e investigan el entorno. Continúan siendo desconfiados y pueden repentinamente resistirse a la realización del examen físico. Tal vez es mejor darles la opción de que sean ellos quienes decidan cómo prefieren iniciar el examen. Comenzar con las maniobras menos molestas permite ganarse su confianza. Preste atención al manejo de los límites y cómo reacciona el niño a ellos.

Observe las conductas del niño y compruebe si coinciden con las documentadas por historia. Evalúe el lenguaje interaccionando con él. Recordar que, en la evaluación del lenguaje, debe considerarse no solo el lenguaje hablado, sino también el receptivo y el gestual. Interrogar si ingiere cosas que no son "comida", como tierra, arena, etc. (hábito de pica).

Examen físico y del crecimiento

Explicar al niño qué se le va a hacer y cómo se lo va a revisar.

Peso: a partir de los 2 años y durante la edad preescolar, el niño crece aproximadamente 2 kg de peso por año.

Medir la longitud corporal y el perímetro cefálico. Determinar percentilos y relacionar con las estaturas de los padres. Relación peso/talla (usar *Tablas OMS* hasta los 6 años).

A partir de los 2 años puede evaluarse el índice de masa corporal: Peso/talla^2 . Se considerará sobrepeso a los valores por encima del percentilo 85 y obesidad a los por sobre el 95. Cifras por debajo del percentilo 5 indicarán bajo peso.

Evaluar subjetivamente la audición y la visión.

Valoración sistemática del desarrollo a través de la PRUNAPE (ver Anexos).

Considerar evaluación de colesterolemia en pacientes con antecedentes familiares de hiperlipidemias o episodios cardiovasculares en menores de 55 años.

Preste especial atención a la detección de:

- ♦ Palidez de piel y mucosas.
- ♦ Alteraciones de la marcha.
- ♦ Alineación del tronco, miembros inferiores y pies.
- ♦ Presencia de caries.
- ♦ Estrabismo.
- ♦ Masas abdominales.
- ♦ Pulsos femorales.
- ♦ Hernias.
- ♦ Fimosis.
- ♦ Testículos no descendidos.
- ♦ Signos de negligencia o maltrato.

El niño
se exprese
de 3 mese

MOTOR GRUESO	LENGUAJE	MOTOR FINO	PERSONAL SOCIAL
SOÑAR LEVANTAR	COG ECO	MANOS SEÑ SEGUIR LENGUAJE	COMUNICAR EL CORDERO SONRIR

» EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

Desarrollo y conductas habituales

Motor grueso

- ♦ Salta con ambos pies (75%).
- ♦ Sube y baja las escaleras alternando los pies.
- ♦ Puede caminar en puntas de pie si se lo piden.
- ♦ Lanza la pelota (más del 90%).

Motor fino

- ♦ Toma el lápiz adecuadamente. Puede imitar líneas. Hace garabatos que pueden incluir el círculo.
- ♦ Apila 8/10 bloques (50%). Imita la construcción del tren.
- ♦ Desabrocha botones.

Lenguaje

- ♦ Dice 50 palabras y expande rápidamente su vocabulario.
- ♦ Dice su nombre completo.
- ♦ Usa frases con sustantivo y verbos (más del 90%). Comprende preposiciones. Emplea plural y pronombres adecuadamente.
- ♦ Los extraños comprenden un 50-75% del lenguaje.
- ♦ Pide bebida, ir al baño, comida, etc.
- ♦ Comprende: arriba, abajo, atrás, dentro.
- ♦ Posee el concepto de "dos".

Socio-adaptativo

- ♦ Empieza a notar las diferencias sexuales. Reconoce su sexo.
- ♦ Emplea taza, cuchara y tenedor.
- ♦ Puede ponerse una campera sin ayuda.
- ♦ Se saca las medias, los zapatos y la ropa sin botones (75%).
- ♦ Algunos controlan esfínteres.
- ♦ Elige sus juguetes preferidos.
- ♦ Escucha cuentos.
- ♦ Presenta conductas repetitivas de orden, generalmente.
- ♦ Imita tareas.
- ♦ Participa de juegos imaginarios, surge el animismo: atribución de vida y conciencia a objetos animados.
- ♦ Puede jugar junto a otros niños, pero sin interactuar (juego paralelo).

El niño puede tener una leve falta de fluidez en el lenguaje (habrá que darle tiempo para que se exprese) o tartamudeo transitorio. Recomendar no tratar de corregirlo, pero, si persiste más de 3 meses, requiere evaluación especializada.

MOTOR GRUESO	LENGUAJE	MOTOR FINO	PERSONAL SOCIAL
SOSTEN LEVANT	COPIA LETRA	SEGUIR MANOS	COMPAR EL COME

Considerar la derivación oportuna de un niño de esta edad si:

- ♦ No pronuncia palabras entendibles.
- ♦ No arma frases utilizando verbos y sustantivos.
- ♦ No cumple órdenes de dos pasos.
- ♦ Presenta marcado aislamiento social.

►► RECOMENDACIONES PARA DAR A LOS PADRES

Alimentación

Recordar que, a esta edad, el apetito suele decrecer debido a una disminución en la velocidad de crecimiento. Continuar con las recomendaciones de los controles de salud de los meses previos (ver Anexos).

Control de esfínteres

Continuar con las recomendaciones de los controles de salud de los meses previos.

Anticipar que puede aparecer constipación, como una manifestación de resistencia al control de esfínteres. En caso de resistencia importante, no insistir y dar unas semanas de tiempo. Estimular el liderazgo de los padres con pautas de crianza claras (ver Anexos).

Sueño

Continuar con las recomendaciones de los controles de salud de los meses previos. (Ver Anexos).

Hábitos y conducta: límites

Continuar con las recomendaciones de los controles de salud de los meses previos (ver Anexos).

El Juego

A esta edad el niño disfruta mucho jugar con agua, masa, plastilina, arcilla, arena (advertir sobre el peligro de los areneros públicos).

Puede tener temores transitorios (perros, ruidos muy fuertes, fobias).

Recomiende juegos que favorezcan la actividad creativa, la actividad física y el desarrollo del juego imitativo (pelotas, cubos, rompecabezas sencillos, lápices de colores, utensilios del hogar no peligrosos, muñecos, cajas, cartones, recipientes en general donde pueda apilar y guardar cosas, juegos de arrastre). Aconseje que no juegue con tierra.

El niño puede imitar los trabajos domésticos de los padres (por ejemplo, barrer, limpiar, cocinar). Puede tener algún objeto transicional.

Estimular la actividad exploratoria y la actividad física supervisada en un entorno seguro con el juego.

Aconseje la participación en las elecciones, cuando sea posible, para estimular su independencia y autonomía.

Recomiende limitar el uso del televisor a menos de una hora diaria y supervisar la programación (ver Anexos).

Salud bucal

Continuar con las recomendaciones de los controles de salud de los meses previos (ver Anexos).

Educación sexual

La curiosidad por los genitales es normal. Recomendar el uso de términos correctos para la denominación de los genitales. Si el niño se masturba, enseñarle que no lo haga en público. Corresponde hablar sobre el cuidado del cuerpo y de su privacidad. Brindar recomendaciones generales para prevenir el abuso infantil (ver Anexos).

Anticipar la curiosidad normal sobre las diferencias sexuales, los genitales y su exploración. Introducir la noción de que ciertas partes del cuerpo son privadas y de que no debe dejarse tocar la zona genital (ver Anexos).

Vacunación

Verificar, en el carnet de vacunación, que tenga las vacunas al día.

Considerar la aplicación de la vacuna para varicela, si no fue aplicada y no padeció la enfermedad (ver Anexos).

Prevención de accidentes

La supervisión constante es fundamental.

Aconsejar nunca dejar al niño de esta edad al cuidado de los hermanos pequeños. No confiar en que el niño seguirá las instrucciones que se le den.

Recordarles a los padres la importancia de conocer las maniobras básicas de primeros auxilios y de reanimación cardiopulmonar para todos los que cuidan del niño. Repasar con ellos la maniobra de Heimlich (se recomienda entregar copia del capítulo de este Manual).

No ofrecer, hasta cerca de los 5 años, elementos ni alimentos que puedan ser aspirados, como salchichas, caramelos duros, nueces, maníes, pochoclo, zanahoria cruda, arvejas, semillas, uvas enteras, pasas de uva, trozos de verdura o fruta dura.

Evitar las camas cucheta o emplear barandas de protección.

Enseñar que no debe seguir a gente extraña.

Comprar juguetes irrompibles (sin partes pequeñas), que sirvan para armar y desarmar.

Viajes en automóvil: utilizar siempre el asiento adecuado, mirando hacia delante en el asiento trasero. Antes de arrancar, asegurarse de que los niños no estén detrás del auto.

Advertir al niño sobre el peligro de correr una pelota o detrás de un perro hacia la calle.

Redoblar el cuidado cuando esté cerca de una calle (ver Anexos).

Otras recomendaciones de crianza

Anticipar la curiosidad normal sobre las diferencias sexuales, los genitales y su exploración. Es recomendable mencionar por su nombre correcto a los genitales.

Introducir la noción de que existen partes privadas del cuerpo y de que no debe dejarse tocar la zona genital por cualquiera.

Los padres deben estar preparados para contestar en forma veraz, clara y acorde al desarrollo del niño, preguntas sobre las diferencias sexuales y el origen de los chicos. Hay libros sencillos que los pueden ayudar. Es recomendable no limitarse exclusivamente al relato de tipo anatómico, sino incorporar los conceptos de capacidad de dar y recibir amor.

En esta etapa ya es conveniente que los padres cuiden de no exhibirse desnudos frente al niño.

Indicar ácido fólico a las madres en edad fértil.

►► PROBLEMAS DETECTADOS Y ESTRATEGIAS

Comente los problemas detectados y plantee las estrategias para solucionarlos.

►► CIERRE DE LA VISITA

Interrogar acerca de dudas que hayan quedado o preguntas pendientes.

Establecer la fecha de la próxima consulta a los 3 años, si no existieran intercurrencias.

» Niños de 3 años

Nuestro paciente está culminando el proceso de convertirse en niño. Ahora se puede conversar y hacer tratos con él. Gessell define a esta edad como “deliciosa”.

Se han instalado algunos aspectos de independencia: control de esfínteres, higiene personal, vestirse, comer, ir a casa de otras personas.

Puede apilar 9-10 cubos para hacer torres.

Corre con seguridad, cambia de velocidad y frena.

Sube escaleras solo, alternando los pies en cada escalón. Salta de un desnivel con los dos pies juntos y pedalea en un triciclo.

Se apasiona por los juegos teatrales.

Construye frases sencillas. Mantiene el soliloquio, usa plurales, conoce 3 o más colores.

Puede vestirse solo con ropas sencillas y, al desvestirse, desprende botones accesibles, desata los cordones de los zapatos y se saca los pantalones.

Imita una cruz (verticalidad y horizontalidad), si alguien se la muestra antes.

Toma adecuadamente el lápiz, dibuja rectas y curvas. Garabatea y, si se le pregunta, dice lo que dibujó. Copia y hace un círculo. El garabato evoluciona durante este período (ver gráfico página 157).

Come solo con la cuchara y derrama poco la comida.

Es atrevido, más seguro, aprende del ensayo y del error, pero todavía sin toda la destreza necesaria. Lejos de contradecir, trata de comprender y cumplir exigencias. Le gusta agradar. Pero sigue necesitando supervisión y límites. Prueba hasta dónde llegan esos límites, antes de empezar a aceptarlos; por lo tanto, puede continuar con berrinches.

Investiga y trata de modificar el entorno inmediato, con el objetivo de conocer el mundo fuera de su familia.

Sabe discernir entre él como persona y los otros. Puede esperar, acatar ciertas normas de comportamiento, compartir, ayudar. Va incorporando el significado de las exigencias sociales.

Es egocéntrico y está tomando conciencia de su individualidad.

Empieza a conocer el "bien" y el "mal".

Expresa verbalmente sentimientos de placer y displacer.

Es imaginativo y comienza a tener sentido del humor.

El desarrollo cognitivo y emocional alcanzado suele determinar, frecuentemente, los miedos infantiles propios de esta etapa.

Es notable cómo se han ido definiendo las características de su personalidad, aunque todavía persisten algunas conductas impredecibles.

► ENTREVISTA

Incorporar al niño a la entrevista, con preguntas simples relacionadas con los temas de su interés: gusto por juegos, amigos, jardín, uso de pañales, etc.

Crear las condiciones para lograr el mayor confort del niño. Permita el uso de algunos juguetes.

Observar el comportamiento del niño en la consulta y la interacción de sus padres con él: cómo manejan los límites, si emplean palabras amables, violentas o despreciativas hacia él, si muestran interés o indiferencia.

Examen físico y del crecimiento

Explique al niño qué va a hacer y hágalo participar.

Peso. Longitud corporal. Determinar percentilos. Relacionar con la altura de los padres.

Relación peso/talla según tablas de OMS.

Índice de masa corporal.

Presión arterial: Se debe **tomar la presión arterial** a todos los niños a partir de los tres años de edad y a los pacientes menores con riesgo de padecer hipertensión arterial (ver *Tablas según edad*).

Evaluar la audición con preguntas a la familia sobre sonidos caseros (contestar cuando se lo llama, timbres, volumen de la música, baile).

A esta edad ya se debe **evaluar la agudeza visual** con cartillas de figuras.

El niño debe estar a tres metros de la cartilla y conviene que en la oclusión del ojo participe la madre; la agudeza visual normal es de 7/10 a 8/10, en cada ojo (ver *Anexos*).

Prestar especial atención a la detección de

- ◆ Estrabismo.
- ◆ Alteraciones en la alineación del tronco (ver *Anexos*) y los miembros.
- ◆ Alteraciones en la marcha.
- ◆ Problemas dentales: caries, mala oclusión.
- ◆ Masas abdominales.
- ◆ Soplos cardíacos.
- ◆ Hernias.
- ◆ Fimosis.
- ◆ Testículos no descendidos.
- ◆ Fusión de labios menores.
- ◆ Pulsos femorales.
- ◆ Signos de negligencia, abuso o maltrato.

Otras evaluaciones de pesquisa

Realizar colesterolemia en niños con factores de riesgo personales o familiares.

Considerar la valoración sistemática del desarrollo (ver Anexos: PRUNAPE).

Hemoglobina, hematócrito o ambos en pacientes con factores de riesgo, si no se realizaron antes.

Evaluación del desarrollo

Evaluar el lenguaje conversando con el niño. Evaluar capacidades de intercambio social como la intención de mirada. Ecolalia: a partir de esta edad debe ser considerada como anormal, pues puede ser indicativa del autismo o sus variantes.

Darle la oportunidad de dibujar o copiar durante la consulta o en la sala de espera.

Desarrollo y conductas habituales

Motor grueso:

- ♦ Marcha segura (camina talón-punta), corre y puede frenar rápidamente.
- ♦ Salta en el lugar (85%) y desde un escalón.
- ♦ Se mantiene en un pie unos segundos (75%). Sube la escalera alternando los pies.
- ♦ Pedalea un triciclo. Abre puertas.
- ♦ Construye torres de 9 cubos. Imita un puente con 3 cubos.
- ♦ Se desviste completamente. Se puede vestir parcialmente (90%).

Motor fino:

- ♦ Copia un círculo. Copia una cruz. Hace un círculo y evoluciona el garabato.
- ♦ Dibuja una persona con tres partes (50%). Dobla un papel en diagonal.
- ♦ Aparea colores (50%).
- ♦ Hace torres.
- ♦ Puede armar rompecabezas sencillos de encastre.
- ♦ Intenta cortar con tijeras de plástico.

Lenguaje:

- ♦ Dice su nombre completo (90%).
- ♦ El lenguaje es mayoritariamente inteligible por extraños (75%); arma oraciones completas, con sujeto y predicado.
- ♦ Utiliza plurales y tiempo pasado. Exhibe un aumento importante del vocabulario y ya combina tres palabras.
- ♦ Frecuentemente pregunta: ¿Por qué? ¿Dónde?
- ♦ Conoce y nombra tres colores.
- ♦ Comprende conceptos como: frío, cansancio, hambre. Comprende preposiciones: en, sobre, debajo y distingue entre “más grande” y “más pequeño”.
- ♦ Comprende y puede cumplir órdenes de dos pasos.
- ♦ Utiliza la forma “yo” para simbolizarse.

Socio-adaptativo:

- ♦ Tiene juego imaginario, imitativo o interactivo.
- ♦ Pensamiento mágico (todo lo que desea aparece en su pensamiento, puede evocar la imagen de un objeto inanimado ausente y conferirle realidad en su pensamiento mágico).
- ♦ Escucha cuentos cortos.
- ♦ Conoce su nombre, edad y sexo. Conoce la diferencia de sexos.
- ♦ Controla esfínteres (90% anal, 85% urinario diurno, 60-70% urinario nocturno).
- ♦ Sus actos tienen propósito. Acepta límites y puede esperar.
- ♦ Todavía puede tener berrinches, más breves y menos violentos que el niño de 2 años.
- ♦ Desea agradar. Puede negociar.

► RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Alimentación

Anticipar que puede ser selectivo con los alimentos y que el apetito puede ser irregular.

Continuar con las recomendaciones realizadas en los controles de salud de los meses previos. Evitar la comida chatarra.

Indicar a los padres que es aconsejable que el niño coma por sí mismo y con cubiertos. Estimular la comensalidad familiar.

(Ver Anexo Alimentación saludable).

Excretas

Asesorar a los padres sobre el entrenamiento del control de esfínteres.

Ver recomendaciones realizadas en controles de salud desde los 18 meses.

(Ver Anexos).

Sueño

Las dificultades del sueño en esta edad pueden ocasionar falta de sueño en la familia. Puede haber pesadillas o terrores nocturnos ocasionales.

Dentro de las posibilidades (compatibilizar con la cultura familiar), estimular al niño a dormir en su propia cama y en un ámbito independiente del de los padres. Si se pasa de cama, devolverlo a la propia. Ofrecer la calma y seguridad que necesita para quedarse solo en la habitación. Es conveniente que los padres creen un ritual a la hora de acostarse, que permita incluir la lectura o el cuento de historias, los cuales mejoran el desarrollo del lenguaje y estimulan la lectura posterior en el niño. Recomendar actividades sedentarias antes de ir a dormir; la excitación o el cansancio, pueden ponerlo irritable. Mantener un horario fijo para acostarlo y un ritual a la hora de acostarse. El niño de tres a cinco años es capaz de dormir durante la noche sin despertarse. A esta edad, generalmente no necesitan dormir la siesta.

Las perturbaciones pasajeras del sueño son comunes en este período. Diversas situaciones pueden ocurrirle durante el sueño: **terrores nocturnos, pesadillas**, etc. Un análisis detallado de los diversos factores y de sus conexiones podrá ayudar a los papás a darse cuenta qué está sucediendo, sin olvidar que la simple reorganización del ambiente ayuda a modificar el hábito del sueño. La mayoría de las dificultades de esta edad para conciliar el sueño obedecen a: 1) Condiciones ambientales: ruidos molestos, televisión excesiva; 2) Irregularidad en el horario de acostarse; 3) Estado de ansiedad o miedo por parte del niño: el pequeño teme ir a dormir. También es frecuente que reclamen una luz encendida. La única diferencia entre un niño que duerme toda la noche y otro que se despierta frecuentemente no es el número de despertares, sino la habilidad del primero para volverse a dormir por sí mismo sin necesidad de intervenciones (ver Anexo).

Hábitos y conducta

Al niño de 3-4 años le resulta posible alejarse tranquilamente algunas horas para ir al jardín de infantes. No tiene miedo de separarse de sus padres si se realiza una adecuada adaptación. Si esto no se logra, se sugiere que sea el otro miembro de la pareja quien lo lleve al jardín, esperando que el despegue sea más fácil.

El niño puede tener leve falta de fluidez en el lenguaje (habrá que darle tiempo para que se exprese) o tartamudeo transitorio entre los 2 y 3 años. Recomendar que es conveniente no tratar de corregirlo.

El niño puede sufrir temores transitorios (perros, ruidos muy fuertes).

Estimular el uso de libros y la lectura, y desaconsejar actividades pasivas, como la TV. En caso de que mire televisión, es conveniente que lo haga en forma supervisada y no más de 1 hora por día.

Estimular la actividad exploratoria y la actividad física supervisada y en un entorno seguro.

Promover las pautas de independencia, favoreciendo las elecciones personales del niño y los contactos sociales (amigos, jardín de infantes).

Baño diario y correcto aseo después de la micción y la defecación.

Recurrir al "no" lo menos posible, pero explicando las consecuencias de un comportamiento inadecuado y, al establecer límites, mantener una actitud firme, consistente y clara. Para la puesta de límites entre los 3 y los 5 años se aconseja una explicación razonada breve, las advertencias y el aislamiento corto.

En este momento evolutivo, los niños tienen un especial interés por su cuerpo y aspectos vinculados con la sexualidad. La curiosidad en esa área hace que adopten conductas de investigación del cuerpo que el adulto debe aceptar. No se ha estructurado aún el pudor.

Los padres deben ser muy claros con respecto al hecho de quiénes pueden tocarle el cuerpo.

Es importante enseñarles a cuidarse, marcar los aspectos de lo íntimo y lo público, como así también las pautas sociales en relación con la sexualidad.

El ingreso al jardín de infantes colabora en la socialización de los niños y refuerza el aprendizaje de normas y rutinas que habían comenzado a aprender dentro del ámbito familiar. Cuando no se han puesto límites adecuados en la familia suelen aparecer dificultades en la adaptación al jardín.

En esta etapa los padres empiezan a tener más libertad, el niño comienza a resolver situaciones en forma más independiente, ya puede esperar y reflexiona al observar a sus padres. Adquiere dos nociones importantes: la noción del tiempo y el interés por aprender. Antes, el niño actuaba según sus pulsiones inmediatas y el placer por satisfacerlas. No podía ni sabía diferirlas. Contaba con el recurso del "capricho". Ahora, aprende que el capricho es inútil y el bienestar afectivo que proporciona la comunicación por otros medios, la expectativa del "enseguida", del "esperá un ratito", enseña la noción del tiempo.

La presencia del adulto sigue siendo imprescindible para reconocer qué decisiones el niño está en condiciones de tomar y ayudarlo en aquellas para las que aún no está preparado.

Las habilidades sociales adquiridas en esta etapa le permitirán desarrollar actitudes de solidaridad, responsabilidad y lo llevarán a internalizar normas y valores culturales.

El juego y los juguetes

Aprende a compartir sus juguetes, imita y dramatiza en sus juegos.

El niño disfruta mucho jugando con agua y arena limpia (advertir sobre el peligro de los areneros públicos), arcilla, plastilina.

Recomendar: juegos que favorezcan la actividad creativa, la actividad física y el desarrollo del juego imitativo (triciclo, soga, pelotas, cubos, rompecabezas sencillos, lápices de colores, objetos del hogar, muñecos, cajas, cartones, recipientes en general donde pueda apilar y guardar cosas. Juegos de arrastre). Aconsejar que no juegue con tierra.

A los 3 y 4 años el niño se aventura a salir al mundo, y a separarse por cortos períodos de los padres o la persona que mejor conoce, y empieza a hacer amigos y a crear vínculos emocionales con adultos y niños fuera de la familia. El mayor interés de un varón son los autos, pero las niñas también pueden compartirlo. El juego con muñecas y animalitos se constituirá en preferido de las niñas imitando a sus madres. También los varones pueden jugar con ellos y no debe desalentarse ni limitarse (ver Anexo Género).

El niño de esta edad necesita que se lo ayude a controlar sus tendencias destructivas, que se le enseñe a ordenar y a tratar de no romper en exceso sus pertenencias. Deberá comprender que existen las pérdidas, aprender a tolerarlas y, también, que debe cuidar sus objetos.

El hecho de poder jugar con tranquilidad a esta edad, usando su imaginación y quedándose solo por momentos con sus juguetes, expresa una buena salud mental.

Dibujar lo ayuda. Aparecen los libros. Es la manera de conservar los momentos. El cuento leído por los padres a la noche lo ayuda a dormirse con algo conocido, en un momento en que le teme a la despedida y a quedarse solo con sus sueños y fantasías. La palabra leída da lugar en el niño al desarrollo de su imaginación: la gente, los sonidos, los paisajes, los colores, los olores. La lectura realizada por una persona querida tiene esa calidad de intimidad.

La televisión también tiene imágenes, pero son cambiantes, necesita manejarlas, por eso también ve dibujitos una y otra vez. Si ve televisión durante mucho tiempo, perderá la oportunidad de jugar y será un mero recipiente, no un participante.

Más allá de los tres años, el niño dibuja un cuerpo cada vez más completo y esto lo va tranquilizando. Comienza a sentir que maneja y conoce su cuerpo entero.

Los juegos sexuales entre los niños demuestran su curiosidad. Entre niños de la misma edad, contribuyen a su desarrollo, siempre que no sean violentos.

Juegan a la mamá y el papá, al doctor, a la enfermera, a los novios, y así satisfacen sus necesidades de ser vistos, de ver y de tocarse.

La posibilidad de poder jugar con otros realmente no se alcanza antes de los tres años. El chico desea jugar con otro niño y, al mismo tiempo, tiene ganas de hacer sólo lo que quiere. La cooperación se logra paulatinamente.

El niño también escenifica situaciones, porque necesita escapar de un mundo que esté gobernado por lo real o racional. Darle una advertencia, 5 o 10 minutos antes de requerirlo para la salida al mundo real –comida, ir a dormir, bañarse– evita situaciones conflictivas.

Aparecen los **amigos imaginarios**, que pueden hacer todas las cosas malas y experimentar todas las cosas buenas con las que fantasea el niño a esta edad. Los primogénitos son en general quienes más los tienen. Los adultos debemos respetar la naturaleza íntima de sus fantasías y no preocuparnos por el alejamiento de la realidad, momentáneo en esta etapa.

Otros juegos de esta edad son los educativos, que fomentan los padres y los jardines de infantes. Ver y hacer les encanta. Resultan apropiados los buzones para cartas, fideos o cuentas para enhebrar, palos con rosca de tornillo, con tuercas, cubos que entran uno en el otro, tarugos que encajan en huecos a golpe de martillo. Los juegos de encaje hechos con ladrillos le son muy útiles. Idéntica finalidad cumplen los rompecabezas sencillos, dominós de figuras, el recortar y pegar. Debe respetarse también el tiempo de relajación del niño. Lo mejor que podemos hacer los adultos es ayudarlos a iniciar un juego, si lo necesitan, y luego deleitarnos viéndolos jugar, sin intervenir (ver Anexo).

Salud bucal

Enseñar el cepillado de los dientes. Indicarlo con poca pasta dentífrica y fluorados después de las principales comidas y antes de dormir. Restringir los momentos de ingesta de azúcar a cuatro por día. Evitar las bebidas carbonatadas y a base de soja.

Indicar flúor solo en situaciones especiales (ver *Supervisión niños 6 meses*). Aplicación tópica de flúor semestral según riesgos de caries y uso de dentífricos con flúor.

Visita semestral al odontólogo. La enfermedad bucal más común a esta edad es la caries dental.

Si sufriera un traumatismo dentario se debe derivar al odontopediatra y no se aconseja el reimplante de los dientes primarios (ver Anexos).

El Jardín de Infantes

Durante la etapa preescolar el niño comienza el jardín de infantes. Esto le permite conocer otros adultos y niños; otras reglas y ampliar su mundo social. Para la familia es una etapa intensa, donde el hijo se encuentra con otros pares y se compara. A esta edad el niño ya puede comunicar sus deseos y necesidades, y puede controlar esfínteres.

El jardín de infantes debiera estar ubicado cerca del domicilio del niño para evitarle largos traslados. Los baños del jardín deben estar adaptados para permitir que el niño tenga fácil acceso a los sanitarios y lavatorios. Es importante avisarles a los padres que durante el primer año de jardín aumentarán los cuadros infecciosos.

En el jardín de infantes se aprenden las primeras normas sociales: saludar, compartir, usar el baño, no discriminar, jugar con otros, los símbolos patrios, etc. Algunos niños necesitan llevar su objeto transicional.

Prevención de accidentes

La supervisión constante es fundamental a esta edad.

Ídem control de salud de 30 meses (ver Anexos).

Otras pautas adecuadas de crianza

Recomendar la demostración de afecto al niño y ser estimulantes y no desvalorizarlo. Respetar sus comentarios y actividades. El niño no tiene una adecuada comprensión de las bromas todavía, por lo que se debe ser cuidadoso con ellas.

Enseñar con el ejemplo.

Favorecer la expresión de sentimientos como alegría, rabia, tristeza, frustración, miedo, etc.

Relaciones familiares y sociales

Promover la comunicación familiar y el cuidado de la salud física y mental de los padres. Evitar que, en lo posible, los problemas laborales afecten la vida familiar.

Crear oportunidades para que los miembros de la familia interactúen entre sí. A los padres, recomendarles pasar tiempo a solas con cada uno de sus hijos; jugar con ellos. Favorecer el contacto con la familia ampliada. Es prudente que los progenitores hablen sobre sus conflictos fuera de la presencia de los niños y que busquen la ayuda posible.

Recordar a los padres la importancia de tomar tiempo para la pareja y para ellos mismos. Evitar que el hijo interfiera excesivamente en la relación de pareja.

Indicar ácido fólico a las madres en edad fértil.

Concurrir a reuniones de educación para la salud. Informarse acerca de los beneficios sociales que brinda la comunidad. Participar en la creación de programas para mejorar la salud de su vecindario.

Dar oportunidad para hablar sobre lo que se hizo durante el día. Hacer conocer al niño de qué se ocupan los padres y cuáles son sus intereses.

Si la familia espera otro hijo, prepararlo adecuadamente para la llegada del hermano.

Ser conciliador en la discusión entre hermanos y no permitir la agresión. En lo posible, tratar de zanjar diferencias con ecuanimidad. Impedir que alcance las cosas más preciadas de su hermano mayor. Considerar la aceptación de la existencia de conflictos y celos como algo normal entre hermanos. No tomar partido siempre por el mismo hermano. No permitir actitudes violentas entre ellos. Reasegurar y demostrar al niño que el amor por él no se modifica.

Considerar la concurrencia al jardín de infantes según la necesidad de la familia y teniendo en cuenta que éste representa un complemento del hogar en la educación, el desarrollo y la socialización.

Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones por la persona a cargo del niño.

Observar conductas que puedan inducir a la sospecha de abuso infantil:

- ♦ Juegos sexuales repetitivos e inapropiados para su edad.
- ♦ Trastornos del sueño.
- ♦ Miedos excesivos.
- ♦ Irritabilidad marcada.

Vacunación

Verificar, en el carnet de vacunación, que tenga las vacunas al día.

Considerar la aplicación de la vacuna para varicela, si no fue aplicada y no padeció la enfermedad (ver Anexo).

►► PROBLEMAS DETECTADOS Y ESTRATEGIAS

Repasar los problemas detectados y plantear las estrategias por seguir frente a cada uno de ellos.

►► CIERRE DE LA VISITA

Preguntar si quedaron dudas, organizar a quién y a dónde deben consultar ante intercurrentias. Planificar la próxima entrevista a un año o según los problemas detectados.

» Niños de 4 años

El niño de 4 años es menos ingenuo y transparente. Tiene un gran desarrollo del lenguaje y de la actividad motriz. Es un preguntador por excelencia. Los “por qué y cómo” son muy frecuentes. Parece charlar para gozar con su propia producción y llamar la atención.

Muestra un marcado interés por las pruebas, proezas, construir, crear y producir. Continúa con enorme energía e impulsividad.

Ha adquirido mayor capacidad de conceptualización.

Empieza a tener más confianza en sí mismo. Es más independiente, sensible e identifica las emociones.

Se da así la combinación de independencia y sociabilidad.

Su pensamiento es egocéntrico, cree que de él depende lo que ocurre. Se siente grande con sus adquisiciones. Sin embargo, continúa con temores irracionales, arranques repentinos y actitudes provocativas y desafiantes.

Tiene mayor concentración en sus actividades y aprende el tiempo de espera, lo que le permite compartir juegos y juguetes.

Reconoce y nombra las partes del cuerpo.

Colabora en pequeñas tareas domésticas.

Hace bromas, imitaciones y goza con ellas.

Corre y puede alternar el ritmo de sus pasos. Puede mantener el equilibrio sobre una sola pierna, vestirse y desvestirse casi sin ayuda, intenta abotonarse, se peina y se cepilla los dientes con supervisión.

Dibuja una cruz. El dibujo de la figura humana consiste en la cabeza, dos apéndices y, a veces, los ojos. Pinta, modela, utiliza tijeras.

Puede contar hasta diez o más y adquiere progresivamente la noción de orden y cantidad.

Puede tener un amigo imaginario.

» ENTREVISTA

Dirigir el interrogatorio al niño, por ejemplo: ¿Cómo te llamas, cuántos años tenés? Por inhibición o pudor no siempre contestará, igualmente permitirá apreciar aspectos de su desarrollo y cotejar la observación con la información dada por los padres. Diríjase a él verbalmente y solicite su colaboración en las distintas maniobras.

Es pertinente crear las condiciones para lograr el mayor confort del niño y permitir el uso de algunos juguetes, lápices, etc.

Examen físico y del crecimiento

Explicarle al niño lo que se le va a hacer.

Realizar mediciones antropométricas. Peso. Talla. Determinar percentilos según tablas de OMS y relacionar con estatura de los padres.

Relación peso/talla.

Calcular el blanco y rango genéticos.

Desde los 4 años y hasta el comienzo de la etapa prepuberal, un niño sano crece a una velocidad baja y constante, aproximadamente una 5-7 cm por año. La velocidad de crecimiento que, durante dos años o más se mantenga en percentilo 10, debe ser considerada como anormal.

El máximo grado en el desarrollo óseo de genu valgo (rodillas en x) fisiológico, se observa a esta edad (8-12 entre los Aquiles), para luego volver a estar alineados a los 7 años, aproximadamente.

Se debe calcular el índice de masa corporal (IMC): peso/talla al cuadrado. Considerar 85-97% sobrepeso y más 97% obesidad. En relación a esta última, implementar estrategias adecuadas de acuerdo a la oferta alimentaria, horarios, comidas obesogénicas, compras en kioscos escolares, actividades físicas activas o pasivas (PC-TV) (ver Anexo: Comidas obesogénicas). Tablas OMS (www.who.int/childgrowth/en)

Evaluar presión arterial y percentilar.

Estimación de la agudeza visual con la prueba de Snellen.

A partir de los 4-5 años se puede evaluar la visión de los colores, por ejemplo, mediante lápices distintos, pidiéndole al niño que separe los rojos de los verdes.

Examen de audición a través del interrogatorio a la familia en relación a sonidos caseros. La audiometría tonal puede realizarse a partir de los 4 años.

Evaluar el lenguaje conversando con el niño. Considere darle la oportunidad de dibujar o copiar.

A partir de los 4 años, las dislalias múltiples deben ser tratadas.

Prestar atención a la aparición de disfluencias. Pueden persistir pronunciaciones de sonidos aislados hasta los 6-7 años (ver Anexo).

Prestar especial atención a la detección de:

- ♦ Estrabismo.
- ♦ Alteraciones en la alineación del tronco y miembros (ver Anexos).
- ♦ Alteraciones de la marcha.
- ♦ Problemas bucodentales: caries, maloclusión.
- ♦ Masas abdominales.
- ♦ Soplos cardíacos.
- ♦ Pulsos femorales.
- ♦ Hernias.
- ♦ Fimosis.
- ♦ Testículos no descendidos.
- ♦ Fusión de labios menores.
- ♦ Evidencias de negligencia o maltrato.

Evaluación del desarrollo

Desarrollo y conductas habituales

Motor grueso:

- ♦ Salta y se balancea en un pie (90%). Sube las escaleras con marcha alternante.
- ♦ Se viste y se desviste casi completamente sin ayuda.
- ♦ Ataja una pelota, puede patear una pelota mientras corre.
- ♦ Usa triciclo.

Motor fino:

- ♦ Abrocha botones. Sube y baja el cierre de cremallera.
- ♦ Usa cepillo de dientes y cubiertos para comer (no cuchillo).
- ♦ Copia un círculo y una cruz. Dibuja la figura humana con tres partes (75%).
- ♦ Corta con tijeras.
- ♦ Hace torres de 8 o más cubos.

Lenguaje:

- ♦ Vocabulario extenso. Oraciones de 4-6 palabras inteligibles para extraños. Pregunta: ¿por qué?, ¿cuándo?, ¿qué? ¿cómo?
- ♦ Puede expresarse en pasado y futuro. Comprende preposiciones. Repite partes de una historia. Tiene sentido de analogías y opuestos.
- ♦ A los cuatro años pronunciará adecuadamente casi todos los sonidos. Se produce una expansión gramatical.
- ♦ Agrupa por color (más del 80%) y forma.
- ♦ Posee el concepto de número.
- ♦ Puede contar hasta 10.
- ♦ Cumple órdenes de dos o tres pasos.

Socio-adaptativo:

- ♦ Control de esfínteres. Van al baño solos sin intervención de los adultos.
- ♦ Participa en juegos en los que toma diferentes roles, se disfraza.
- ♦ Tiene amigos imaginarios. Puede no diferenciar fantasía de realidad.
- ♦ Noción de sentimientos propios y ajenos.
- ♦ Aceptan normas de la casa.
- ♦ Aprende a distinguir entre lo bueno y lo malo.
- ♦ Pensamiento mágico. Reconoce alguna letra.
- ♦ Puede compartir. Espera turno.
- ♦ Tiene preferencia por el padre del sexo opuesto.
- ♦ Exploración sexual.
- ♦ Conoce y repite canciones.

Considerar la valoración sistemática del desarrollo.

► RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Alimentación

Explicar a los padres los grupos básicos de alimentos y lo que aportan:

- ◆ Proteínas: carnes vacunas, aves y pescados. Huevos.
- ◆ Grasas y calcio: Quesos, leche y sus derivados.
- ◆ Hidratos de carbono y fibras: cereales y sus derivados, legumbres (porotos, lentejas, garbanzos).
- ◆ Frutas y dulces.
- ◆ Frutas y verduras: Hidratos de carbono, vitaminas, minerales y fibras.

Recordar que la dieta debe estar basada en cereales y sus derivados (harinas y pastas) legumbres, verduras y frutas (al menos una vez por día debe ingerir algún derivado vegetal crudo).

A partir de los 2 años, los lácteos deben ser parcialmente descremados. La ingesta de carne desgrasada debe formar parte de la dieta 3 o 4 veces por semana.

Restringir la comida chatarra: fiambres, salchichas, embutidos, hamburguesas industriales productos de copetín, gaseosas, jugos industriales, golosinas y galletitas.

Tener en cuenta que el exceso de fibras limita la absorción de micronutrientes.

Recomendar la utilización de alimentos sencillos, caseros y de fácil cocción, y con relación a la región donde habita la familia, sus costumbres y capacidad económica.

Priorizar las estrategias familiares de compra.

Emplear alimentos nutritivos y diferentes sabores, no limitar el menú sólo a las comidas que le gustan al niño.

Es importante que él decida cuánto comer.

Usar agua para calmar la sed (ver Anexos).

Comer con la familia en horarios regulares, estimulando el diálogo y el televisor apagado.

Instruir acerca del lavado de manos y normas adecuadas a la hora de las comidas.

Enseñar al niño a alimentarse solo, manteniendo siempre constante supervisión, debido al riesgo de aspiración alimentaria a esta edad.

Anticipar que el apetito puede parecer escaso. No exigir la ingesta a toda costa y explicar a los padres que el apetito puede disminuir en relación a la reducción de la velocidad de crecimiento. Recordar que la puja por la comida es una forma de llamar la atención.

Recomiende a los padres demostraciones explícitas de afecto, límites claros que consideren un orden alimentario.

Excretas

Algunos niños no han logrado todavía el control vesical de esfínteres (enuresis primaria). Investigue antecedentes familiares, límites y causas biológicas.

Pueden producirse regresiones en el control de esfínteres, que deben ser consideradas normales, porque el niño asume una gran responsabilidad para determinar la necesidad de ir al baño.

Ante episodios de enuresis nocturna, luego de un período de control mayor de 6 meses, deberán investigarse situaciones emocionales asociadas, como cambios, separaciones, mudanzas, nacimiento de hermanos, estrés familiar. Considerar la posibilidad de abuso sexual.

Descartar infección urinaria y poliuria.

Recomendar estimular hábitos independientes de higiene y control de esfínteres (ver Anexo).

Sueño

Ídem control de los 3 años (ver Anexo).

Hábitos y conducta

Estimular la actividad exploratoria, la actividad física y recreativa acordes a su edad.

Enseñar a disminuir el sedentarismo promoviendo actividades deportivas al aire libre, supervisadas y en un entorno seguro.

Limitar las horas de televisión a no más de dos por día y participar en la selección de los programas y mantener el aparato apagado durante las comidas.

Como en todos los controles de salud previos, recomendar el uso de libros y la lectura interactiva. Asignarle tareas sencillas, como poner y limpiar la mesa, planear el menú.

Promover las pautas de independencia favoreciendo las elecciones personales del niño y los contactos sociales (amigos, jardín de infantes). Estimular al niño a que exprese sus sentimientos. Enseñarle a manejar sus miedos y a resolver los conflictos sin violencia.

No condicionar el afecto al comportamiento del niño ("no te quiero más"). Si el niño presenta una conducta inadecuada, expresar que no se está de acuerdo con ella, sin descalificarla.

Enseñar a los padres que no se debe someter al niño a castigo físico y a las humillaciones.

Enseñar el respeto a la autoridad, promover la autodisciplina y el control del impulso (ver *Límites*).

Reconocer que el niño puede aceptar y cumplir un trato. Estimular el reconocimiento de los logros y su autoestima. No recurrir nunca a la culpa como elemento de presión.

El juego y juguetes

A los cuatro años agrega imaginación y fantasía a los juegos; elige el papel que quiere representar, juega con otros. Es adecuado promover elementos de juego dentro del hogar: lápices, pinceles, instrumentos musicales, rompecabezas, muñecos, pelotas, sogas, juegos de salón (ver Anexo).

Educación sexual

Emplear correctamente los términos que identifican los genitales. Es normal la curiosidad de los niños acerca de las diferencias de sexo y del nacimiento de los niños.

Explicar al niño que hay zonas de su cuerpo, y del de los demás, que son "privadas" y que no deben ser expuestas porque sí ni permitirse que sean tocadas por los extraños. Estar atentos a los signos indirectos y directos de abuso sexual.

Aconsejar no limitar la manipulación de sus genitales como parte del aprendizaje y explicar que es normal que le ocasionen sensaciones placenteras. Contestar las preguntas acerca de la sexualidad y la maternidad en forma sencilla, con lenguaje comprensible, sin extenderse más allá de lo que el niño quiera saber. No limitar la información a los aspectos anatómico y fisiológico, sino incluir las nociones de dar y recibir amor (ver Anexo).

Salud bucal

Ídem control de salud de 3 años de vida.

La succión del dedo puede aceptarse hasta los 4 años, más allá de esa edad es probable que produzca alteraciones irreversibles en los maxilares.

Desaconsejar los caramelos masticables y los chicles con azúcar (ver Anexo).

Fluor: indicaciones similares a edades anteriores. Cepillado con pastas dentífricas con fluor.

Prevención de accidentes

Mantenerlo en lugar libre de humo de cigarrillo.

Evitar el acceso a fósforos y no permitir el uso de artículos de pirotecnia.

En los viajes en automóvil, colocar al niño en el asiento trasero (en nuestro país, no se permite a menores de 12 años viajar en el asiento delantero). Puede usar el cinturón de seguridad de cadera elevando la posición del niño con un almohadón o asiento suplementario. Con los cinturones inerciales pueden producirse lesiones del cuello.

Comenzar la educación vial: emplear casco si usa bicicleta o patín, caminar del lado de la pared por la vereda, reconocer entradas de garajes y los medios luminosos y acústicos para advertir sobre la salida de vehículos, cruzar por los lugares permitidos para peatones.

Los adultos deben ser muy cuidadosos del respeto de las normas de seguridad vial, pues los niños, propios y ajenos, están aprendiendo del ejemplo que ellos le brindan cotidianamente.

Se les debe enseñar no solo el nombre sino la dirección de su casa.

Evitar transportarlo en bicicletas y, si se lo hace, colocarlo en asiento adecuado y con casco.

Debe aprender su nombre y apellido, dirección y número de teléfono (ver Anexo).

A partir de los 4-5 años es recomendable que los niños aprendan a nadar por cuestiones de seguridad, recordar que el alerta debe ser permanente cuando estén en las piscinas, pues siempre corren riesgo de ahogamiento. Colocar elementos de seguridad a su alrededor.

Los niños y los perros

La presencia de un perro en la casa puede ser para los niños una experiencia positiva a partir de los 4-5 años. En niños menores de esa edad suelen observarse accidentes por mordeduras, por una actitud dominante del perro, aun sin provocación.

Nunca dejar a un niño solo con un perro, aunque sea conocido, y enseñar que no se lo moleste cuando el animal come. Observar sus presencias donde los niños van de visita y verificar que un adulto responsable esté a su cuidado. Recordar que un perro que mordió una vez, vuelve a morder y que uno que nunca lo ha hecho puede hacerlo por primera vez.

Realizar controles periódicos para descartar patologías, desparasitar y efectuar vacunas.

Relaciones familiares y sociales

Consolidar una autoestima adecuada.

Ver controles de salud de edades anteriores. Además, realizar actividades que también gratifiquen a los adultos, para que puedan disfrutarlas juntos (por ejemplo: visitar sitios de interés, como museos o parques, juegos de salón, lecturas, deportes, etc.).

Estimular el contacto con otros chicos de su edad, fuera del ámbito escolar y ayudarlo a que pueda quedarse solo con ellos. Desarrollar relaciones familiares ampliadas y sociales (actividades barriales o comunales, culturales, deportivas o religiosas).

Promoción del ingreso escolar exitoso. Conversar con él acerca de nuevas oportunidades, amigos, actividades. Concurrir juntos al lugar, para que lo conozca.

Tener expectativas razonables respecto de los maestros y aceptar la diversidad entre los niños.

En los casos necesarios, promover las ayudas sociales y comunitarias en el lugar: seguro médico/bonos de comida, vivienda, grupos de autoayuda, educación para la salud, huertas comunitarias.

Vacunación

Verificar, en el carnet de vacunación, que tenga las vacunas al día.

Los niños que no han recibido vacunación alguna o que han perdido la constancia de las inmunizaciones recibidas, deben ser considerados susceptibles y, por lo tanto, recibir las vacunas correspondientes (ver Anexos).

» PROBLEMAS DETECTADOS Y ESTRATEGIAS

Repasar los problemas detectados y plantear las estrategias por seguir frente a cada uno de ellos.

» CIERRE DE LA VISITA

Preguntar si quedaron dudas y dar la oportunidad de repreguntar. Planificar charlas para próximas entrevistas según los problemas detectados. Dar pautas para las interurrencias.

Establecer la fecha de la próxima visita en un año, si no existieran complicaciones.

» Niños de 5 años

La primera infancia está finalizando. Ha quedado atrás el niño de 4 años, que se relacionaba con el entorno de manera algo impulsiva y torpe. El niño de 5 años ha desarrollado precisión en su actividad motriz, agilidad, equilibrio y gracia.

Con movimientos más económicos que antes, explora el mundo físico y social. Tiene mayor capacidad de atención y de control de sus impulsos, por lo que puede ver y escuchar los detalles y obedecer reglas. Estas cualidades, sumadas al desarrollo amplio del lenguaje, lo deja mejor ubicado frente a la realidad y con mayor capacidad para alejarse del hogar. Es incansable y curioso.

Es la etapa del comienzo del preescolar, hito importante en esta edad. Las capacidades adquiridas lo ayudarán a la adaptación en este nivel, sobre todo si ha tenido experiencia en el jardín. Ha desarrollado capacidad de juego asociativo, no tan solitario o paralelo, por lo que puede tener amigos. Es ya capaz de entender reglas de juegos colectivos, pero todavía no puede comprender claramente las necesidades de los demás y tiende a mantener sus puntos de vista.

Es, en general, obediente; empieza a asumir algunas responsabilidades. Ha adquirido sentido del orden y constancia en sus actividades, colabora con su aseo y con los quehaceres de la casa. Da poco trabajo para dormir. Se puede confiar en él, pero la noción de peligro no es

completa y debe ser supervisado por adultos para la prevención de accidentes vinculados con su mayor independencia y desplazamiento fuera del hogar.

Es más dueño de sí mismo y se relaciona con el entorno en forma amigable.

No obstante, puede continuar con temores irracionales (lluvia, oscuridad, truenos, etc.). Ha progresado en él el sentido de vergüenza y deshonra, a la par que ha aprendido algunas triquiñuelas.

Reconoce la izquierda y la derecha de su cuerpo.

Dibuja la figura humana con cabeza tronco y extremidades (ver gráficos). Usa colores, hace collage y pegamentos, moldea y lo realiza con una idea definida.

Se interesa por los números y las letras, puede escribir su nombre.

Le apasionan los cuentos leídos por los adultos y crea sus propias historias.

Continúa con juego simbólico e incorpora los reglados.

►► ENTREVISTA

Es recomendable incluir al niño en la entrevista y adaptar el interrogatorio a su capacidad de comunicación. Esto permitirá observar ciertos aspectos y cotejarlos con los relatos de los padres.

Crear las condiciones para lograr el mayor confort del niño. Permitir el uso de algunos juguetes, lápices, etc. Dirigirse a él verbalmente y solicitar su colaboración en las distintas maniobras.

Observar el comportamiento del niño en la consulta y la interacción de los padres con él. Observar la relación de los padres entre sí y con los hermanos.

Efectúe comentarios favorables sobre el paciente.

Examen físico y del crecimiento

Explique al niño lo que va a hacer.

Realizar mediciones antropométricas. Peso. Talla. Determinar percentilos en tablas de OMS

Relacionar con estatura de los padres. Relación peso/talla.

Como las consultas de la supervisión de la salud se realizan una vez por año es importante realizar: **Índice de Masa Corporal** (peso/talla al cuadrado). Percentilar y evaluar posibilidad de sobrepeso u obesidad (ver *Niños de 4 años, Anexo Comidas obesogénicas*). Tablas OMS (www.who.int/childgrowth/en)

Al medir a un niño con las tablas correspondientes se lo percentila entre el 97% y el 3%.

Por encima del 97, consideramos talla alta y, por debajo del 3, talla baja. Posteriormente se compara la talla hallada con la de sus padres, para saber si está dentro de lo esperado. Si no es congruente debe buscarse alguna causa para justificarla, ya sea por tallas de otros familiares directos, retraso por crecimiento intrauterino o enfermedades sintomáticas o asintomáticas (por ejemplo: Celiaquía).

Para ello, **calcular el blanco y rango genético**.

Si es una niña: estatura de la madre + estatura del padre - 12,5/2 = blanco genético.

Si es un niño: estatura de la madre + estatura del padre + 12,5/2 = blanco genético.

Rango genético: blanco genético +/- 8,5.

Tomar la presión arterial en brazo derecho y comparar valores con tablas.

A partir de esta edad se puede evaluar la agudeza visual con la cartilla de Snellen, con letras y números. Entre los cinco y seis años alcanza la agudeza visual del adulto, 10/10 en cada ojo.

Evaluar la audición y visión.

Evaluar el lenguaje conversando con el niño. Considerar darle la oportunidad de dibujar o copiar (ver Anexos).

Preste especial atención a la detección de

- ◆ Estrabismo.
- ◆ Alteraciones en la alineación de la columna (ver *Anexos*).
- ◆ Alteraciones de los miembros y en la marcha.
- ◆ Problemas dentales: caries, mala oclusión.
- ◆ Masas abdominales.
- ◆ Soplos cardíacos.
- ◆ Hernias.
- ◆ Fimosis.
- ◆ Testículos no descendidos.
- ◆ Fusión de labios menores.
- ◆ Pulsos femorales.
- ◆ Signos de negligencia o maltrato: heridas, hematomas.

Otras evaluaciones de pesquisa

Considerar la determinación de la colesterolemia en niños con factores de riesgo personales y familiares.

Se recomienda realizar audimetría tonal y examen de la agudeza visual previo al ingreso a la escuela primaria.

Evaluación del desarrollo

Considere la opinión de las maestras de preescolar acerca de las capacidades y conductas de los niños debido a la experiencia, preparación y posibilidad de comparación que poseen.

Es frecuente que sean ellas quienes detectan las alteraciones del desarrollo o de la conducta.

No subestime la opinión de los padres y los docentes, pues puede ser una oportunidad perdida sobre una alteración a prevenir o tratar (ver *Anexo Problemas del aprendizaje*).

Los docentes y las familias tienen una visión longitudinal y diaria más completa que la del médico, que cuenta con un limitado tiempo durante la consulta.

Desarrollo y conductas habituales

Motricidad gruesa

- ◆ Mantiene equilibrio en puntas de pie, se mantiene en un pie varios segundos.
- ◆ Salta una cuerda y alternativamente en un pie. Retrocede talón-punta (50%).
- ◆ Reconoce derecha e izquierda en sí mismo.

Motricidad fina

- ◆ Usa cepillo de dientes y peine. Se viste casi completamente solo.
- ◆ Se ata los cordones y abrocha botones.
- ◆ Dibuja la figura humana con seis partes (75%). Copia cuadrado, triángulo y, con dificultad, rombo. Colorea dentro de límites. Copia letras y números.
- ◆ Dobla papel en diagonal (90%). Cuenta con los dedos de la mano.

Lenguaje:

- ◆ Completo en estructura y forma (tiempos de verbo apropiados).
- ◆ Dislalias ocasionales. Oraciones complejas con oraciones subordinadas hipotéticas y condicionales. Respuestas más ajustadas a las preguntas. Pregunta: ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona esto? ¿Qué quiere decir? ¿Quién lo hizo?
- ◆ Pregunta el significado de las palabras. Conoce, como mínimo, cuatro colores.
- ◆ Frecuentemente escribe su nombre.
- ◆ A los cinco años, la dicción debe ser correcta, los enunciados estarán adecuadamente contruidos y tendrán significación y sentido comprensibles.

Socio-adaptativo:

- ◆ Sabe su edad, nombre completo y, ocasionalmente, su dirección. Cuenta hasta 10 o más.
- ◆ Concepto de tamaños correlativos y formas complementarias. Posee sentido de tiempo (ayer, mañana).
- ◆ Cuenta una historia simple, comenta su vida familiar.
- ◆ Tiene juego asociativo y con compañeros imaginarios.
- ◆ El juego toma características propias del sexo al que pertenece, pero en forma determinante.
- ◆ Se interesa por cómo nacen los niños. Tiene pudor a mostrar sus genitales a extraños.

►► RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Alimentación

El apetito todavía puede parecer escaso.

Recomendar cuatro comidas diarias y no más de dos colaciones.

Dieta balanceada y no superar 500 ml de leche diaria, incluida la ingesta de otros lácteos, preferentemente descremados.

Continuar con las recomendaciones en alimentación de edades anteriores (ver *Niños de 4 años*).

Excretas

Anticipar problemas de constipación (rechazo a evacuar fuera del hogar).

Muchos niños presentan **constipación oculta**, evacuan todos los días, pero menor cantidad que la que debieran, suelen ser postergadores de la defecación por juegos o televisión.

Pueden tener dolor al defecar y heces de gran volumen. Si se establece este hábito pueden persistir constipados durante la adultez, con las complicaciones que ésta acarrea. Es importante reestablecer hábitos evacuatorios saludables, enseñar a los niños sobre su importancia, colocar límites en los postergadores, estimular la ingesta de fibras y líquidos.

Recomendar hábitos independientes de higiene y control de esfínteres (ver *Anexo*).

Sueño

Ídem control de salud de los 4 años (ver Anexo).

Hábitos y conducta

Ver control de salud en los meses previos.

Anticipar la preocupación por las enfermedades y la muerte.

Estimular la actividad exploratoria, la actividad física y recreativa, que desarrolle la imaginación de acuerdo a su edad. Estimular el empleo de libros y la lectura interactiva.

Limitar las horas de televisión a no más de dos por día y participar en la selección de los programas. Promover las pautas de independencia favoreciendo las elecciones personales del niño y los contactos sociales (amigos, jardín de infantes).

Los límites deben ser claros, lógicos, adecuados a la edad y firmes. Explicar que si el niño presentara una conducta inadecuada, los padres deben expresar no estar de acuerdo con ella, sin descalificarlo. El niño debe ser corregido en privado. Explicar las consecuencias en caso de incumplimiento. Es contraproducente enunciar sanciones que no se cumplirán.

Recordar que, para ser eficaces, los llamados de atención deben realizarse en el momento.

En caso de incumplimiento, puede ser eficaz el aislamiento social por pocos minutos (un minuto por año, hasta un máximo de 5 minutos en mayores de un año) o privarlo de actividades placenteras (televisión, juguetes con la computadora, etc.).

Puede suceder que se presente una muerte cercana y habrá que aconsejar a los padres sobre como informar y qué hay que observar (ver Anexo Duelo).

Educación sexual

Instruya a los padres que respondan a las preguntas del niño sin explicar más de lo que él pretende saber. El niño debe saber a esta edad las diferencias sexuales.

Considerar la masturbación como un hecho normal; cuando se convierte en compulsiva o se realiza en lugares inapropiados, posiblemente indique un trastorno emocional subyacente. Indague sobre las características de un día de vida.

Enseñar a los padres que indiquen al niño que los genitales no se tocan en público y, que si lo desean, lo hagan en soledad.

Brinda pautas de cuidado corporal propio y de los demás.

Esté atento a las posibilidades de abuso sexual, observe signos directos e indirectos.

El juego

Después de los cinco años, los juegos de los varones y de las niñas son ya bastante diferentes.

Los varones juegan a conquistar, principalmente mediante juegos de acción. Imitan personajes que van variando en el tiempo, pero que tienen que ver con el misterio y el poder, a veces extraordinario, que desearían tener para no sentirse a merced de un mundo donde son débiles e indefensos.

Las niñas juegan con muñecas, preparan comida y la sirven. Buscan identificarse con su madre y con el entorno femenino. Se disfrazan.

A veces, pueden ser estimuladas en exceso respecto de estas identificaciones sexuales, vistiéndolas con atuendos de formas adultas; se pierden de vista, entonces, las posibilidades emocionales reales a su edad y se las pone en riesgo de actuaciones sexuales que son peligrosas.

El jardín de infantes le permite al niño de esta edad compartir experiencias, controlar sus impulsos y estimular su lenguaje y sus posibilidades de comprensión. Los juegos electrónicos le permiten también penetrar en un mundo de misterios y aventuras, y vencer obstáculos (ver Anexo).

Salud bucal

Ídem control de salud de 4 años.

Visita al dentista al menos una vez por año (ver Anexo).

Prevención de accidentes

Enseñarle a nadar no previene situaciones de riesgo. Limitar el uso de la pileta de natación sólo a momentos bajo la supervisión de un adulto.

Instalar, alrededor de las piscinas, una protección metálica de más de 1,20 m de altura y colocar candado cuando no se la utilice. No cubrir la pileta.

La mayoría de los niños ha adquirido, recién a la edad de 5 años la aptitud adecuada para comenzar el aprendizaje organizado, placentero, de la natación realizado por docentes capacitados en aguas claras sin movimiento (piscinas o similares). Está absolutamente proscripta la natación en "aguas oscuras con movimiento" (ríos, lagos, mar). Mantener en cualquier circunstancia y ambiente acuático el uso del chaleco salvavidas, la proporción adultos-niños en embarcaciones y todo el resto de medidas comentadas previamente.

En los viajes en automóvil, colocar al niño en el asiento trasero (en nuestro país no se permite a menores de 12 años viajar en el asiento delantero). Se puede recurrir al cinturón de seguridad de caderas elevando la posición del niño con almohadón o asiento complementario, para evitar que la faja comprima el abdomen. Con los cinturones inerciales de hombro y cadera pueden producirse lesiones de cuello. Continuar con la educación vial.

Relaciones familiares y sociales

Dedicar al niño tiempo individual. Realizar actividades que también gratifiquen a los adultos para que puedan disfrutarlas juntos (por ejemplo, visitar sitios de interés, como museos o parques, juegos de salón, lecturas, deportes, etc.).

Permitir que el niño tenga cierta privacidad cuando se vista, se desvista o se bañe y que los padres del sexo opuesto guarden privacidad. Manejar en forma constructiva las situaciones de conflicto que se susciten en la familia. Desarrollar relaciones familiares armónicas.

Dar oportunidad para hablar sobre lo que se hizo durante el día. Responder las preguntas en forma real y según su grado de comprensión.

Fomentar estrategias adecuadas para el cuidado del niño en horarios de trabajo de los padres y fuera del horario escolar.

Asegurar el cumplimiento de las recomendaciones por la persona a cargo del niño.

Repasar este ítem en el control de salud de edades previas.

Vacunación

Verificar el carnet de vacunación. Considerar la aplicación de la segunda dosis de HAV si no fue aplicada y no padeció la enfermedad (ver Anexo).

Problemas detectados y estrategias

Repasar los problemas detectados y plantear las estrategias por seguir frente a cada uno de ellos.

» CIERRE DE LA VISITA

Preguntar si quedaron dudas y si desean repreguntar algo. Organizar a quién y a dónde deben consultar frente a las interurrencias. Aconsejar ácido fólico a mujeres en edad fértil. Establecer la fecha de la próxima visita en un año, si no existieran complicaciones.

►► Niños de 6 y 7 años

El niño de esta edad ha culminado un proceso evolutivo con profundos cambios físicos y psicológicos.

Todavía, puede ser excitable, pero los impulsos conductuales y motores, como así también la intensidad de los sentimientos hacia los padres, tienden a disminuir. Suele ser inquisitivo, autoritario y tumultuoso. Le gusta ser querido y elogiado. Le cuesta perder y aceptar las críticas. A la par, muestra inclinación por rituales, convenciones y tareas sociales rutinarias.

Su pensamiento es más realista y va perdiendo el juego simbólico.

Está penetrando en nuevos campos de acción, sobre todo fuera de su casa, pero, como todavía no está capacitado para tomar decisiones consistentes, el control de los padres debe mantenerse estrechamente, sin cercenar su independencia.

Debe adaptarse y compatibilizar dos mundos: el de su casa y el de la escuela.

El ingreso escolar es un paso de gran trascendencia y muy movilizador. Debe conocer un escenario social con costumbres extrañas que lo pueden desorientar, pero que lentamente contribuirán a su autoorganización al brindarle una escala de valores y exigirle la consideración de los demás. Las tensiones son fuertes. La maestra, al principio personaje amenazador, se convierte en una madre auxiliar en la cual el niño fija

su afecto y le permite reforzar su seguridad fuera de los límites del hogar. Una maestra que no responde a ese perfil puede ser muy contraproducente.

A esta edad, el niño suele evidenciar sus preferencias, que toman carácter de verdadero gusto, y permite a la familia satisfacer estas inclinaciones en la elección de actividades. Adquiere y acepta el concepto de Dios y difícilmente discuta sobre esto antes de los 7 años.

Tiene interés por su estructura anatómica, pero va disminuyendo el referido a temas específicamente sexuales. Se preocupa por la muerte y tiene conciencia de la posible muerte de seres queridos (ver *Anexo Duelo*). Relaciona entonces la enfermedad, la vejez, los remedios y el hospital con la muerte; aspectos que no pueden dejar de ser incluidos en la atención de nuestro paciente de esta edad.

El pediatra debe incluir al niño en la consulta y estar alerta a los problemas que traen aparejadas las exigencias intelectuales y sociales de este período (ver *Anexo Problemas de aprendizaje*).

Es fundamental detectar factores de riesgo social, ambiental y biológico, y si existe trabajo infantil. Indagar sobre violencia familiar, barrial, o escolar.

► ENTREVISTA

La capacidad verbal desarrollada a esta edad permite, que al incluirlo en el interrogatorio, se fomente la motivación y la responsabilidad en el cuidado de su salud.

Es menester crear las condiciones para lograr el mayor confort del niño y permitir el uso de juguetes.

Dirigirse al niño tanto como a los padres.

Observar el comportamiento del niño en la consulta y la interacción de los padres con él: cómo manejan los límites, si emplean palabras amables, violentas o despreciativas, si muestran interés o indiferencia, si le permiten al niño responder por sí mismo cuando el médico lo interroga.

Observar si el niño interrumpe la conversación y, en ese caso, qué actitud adoptan los padres; si se desviste solo y se ubica en la camilla sin ayuda. En la edad escolar los niños presentan pudor; entonces, el examen físico se puede realizar por partes mientras se mantienen cubiertas las otras partes del cuerpo.

Examen físico y del crecimiento

Peso. Talla (determinar percentilos). A partir de los 6 años, por recomendación de la SAP, deben usarse las tablas tradicionales de 6 a 19 años.

Relaciónelos con la altura de los padres.

Índice de masa corporal (IMC): Como la próxima evaluación de la salud será en un año y dada la advertencia sobre sobre peso y obesidad, el IMC será importante para realizar recomendaciones sobre hábitos saludables (ver *Niños de 4-5 Años y Comidas obesogénicas*). Tablas OMS.

Velocidad de crecimiento: determinar percentilos.

Control de presión arterial: determinar percentilos.

Relación peso/talla.

Determinar el blanco genético

Si el paciente es varón: talla de la madre + talla del padre más 12,5/2. Si el paciente es varón se sumará, a la talla del padre, la de su madre más 12,5 cm y la suma se dividirá por 2.

Si la paciente es mujer: la talla del padre + la de la madre menos 12,5 cm/2.

El **rango genético** indica los límites normales de dispersión de la talla para una pareja determinada y se obtiene sumando y restando, al blanco genético, 8,5 cm.

Si la talla de un paciente está por fuera de su intervalo genético deberá ser evaluado, aunque se encuentre dentro de percentilos normales para edad y sexo.

Explorar la agudeza visual con tablas específicas colocando al niño a 3 metros de distancia.
Explorar la audición.

Realizar control ortopédico completo. Maniobra de Adams.

Revise los genitales en presencia y con la colaboración de los padres.

(Ver Anexos).

Prestar especial atención a la detección de

- ♦ Respiración bucal.
- ♦ Dislalias.
- ♦ Alteraciones de la postura: escoliosis y cifosis (ver *Anexos*).
- ♦ Alteraciones de la marcha.
- ♦ Estrabismo, forias.
- ♦ Caries, mala oclusión.
- ♦ Fimosis.
- ♦ Indicadores físicos de negligencia, maltrato o abuso.

Evaluación del desarrollo

Considerar la semiología del cuaderno, del dibujo de la figura humana y del dibujo de la familia (ver Anexo).

Desarrollo y conductas habituales

Motor grueso

- ♦ Presenta gran destreza y actividad motora. Salta la cuerda, trepa árboles, faroles, etc. Usa bicicleta. Se la pasa jugando por todos lados.

Motor fino

- ♦ Se ata los zapatos, se peina, se baña, se viste y desviste sin ayuda.
- ♦ Dibuja la figura humana con 12 partes o más. Dibuja y colorea sin salirse de la línea, los varones dibujan aviones, trenes, barcos y las nenas, casas, vestidos, flores.
- ♦ Emplean la tijera, recorta y pega figuras. Modela con arcilla. Arma y desarma.
- ♦ Usa herramientas, como el martillo. Copia un rombo.

Lenguaje y escritura

- ♦ Cuenta hechos recientes.
- ♦ A los 6 años, reconoce el alfabeto y cuenta hasta 20. Copia letras de imprenta (cursiva hacia los 7 años). Tiende a invertir letras y números. Puede invertir sílabas. Tiende a reemplazar palabras por otras análogas. Intercambia pronombres. A los 7 años, lee.

Socio-adaptativo

- ♦ Siente temor por ruidos desconocidos, enfermedades y heridas.
- ♦ Respeta reglas de la escuela. Regula su atención y comportamiento.
- ♦ Tiene pesadillas frecuentes, pero en disminución.
- ♦ Empezará a identificar derecha-izquierda en el otro. Empieza a conocer calles y a ubicarse geográficamente.
- ♦ Manifiesta sus deseos y sus gustos son más definidos (por ejemplo, elige la ropa). Continúa con explosiones emocionales, que irán disminuyendo con la edad.
- ♦ Tiene desarrollo del sentido de sí mismo, ético y de la propiedad.
- ♦ Realiza juego imaginativo con los objetos de la casa, muy activo o sedentario, pero sostenido.
- ♦ Elige amigos y tiene preferencia por compañeros. Le gustan los juegos de mesa.

Evaluación del área cognitiva

El escolar se caracteriza por alcanzar el **pensamiento concreto**, es decir, puede realizar operaciones mentales, pero depende de la percepción. A los 7 años percibe la reversibilidad de una acción; puede comprender que $2 + 1 = 4 - 1$. Antes, entendía las dos operaciones, pero no podía asociar que el resultado era el mismo. Esta percepción le permite realizar sumas y restas ligadas con la realidad, usando elementos concretos.

La conservación de la materia le permite entender que las propiedades de un objeto no cambian, aunque se modifique su forma interior; primero, incorpora la noción de longitud, luego la de peso y, finalmente, la de volumen: un kilo de plumas pesa igual que un kilo de plomo, aunque ocupen un volumen distinto, para un niño más pequeño las plumas pesarán más (ver *Anexo: Problemas en el aprendizaje escolar*).

►► RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Muchos de los siguientes temas podrán ser conversados directamente con el niño; de esta manera se lo involucrará en su propio cuidado.

Alimentación

Insista sobre la importancia de lograr buenos hábitos alimentarios.

Corresponde informar sobre los riesgos que implican para la salud, actual y futura, la falta de cuidados en la alimentación.

Debe realizarse controles con cierta frecuencia, pues es el período de aumentos excesivos de peso.

Anticipar el aumento del apetito y que se trata de un momento en el cual la instalación de la obesidad es posible.

Respetar los horarios de comida para evitar llegar con hambre exagerado. Estimule el desayuno.

Evitar la ingesta de alimentos de venta no controlada y el consumo de comida chatarra,

incluidos los kioscos escolares (ver *Anexo Alimentos obesogénicos*). Prestar atención al tiempo excesivo dedicado a actividades pasivas (televisión y computadoras).

Asegurar el aporte adecuado de flúor según necesidad y en relación al fluoruro de cada región o ingesta de agua comercial (ver *Anexo Salud Bucal*).

Aconseje ácido fólico en mujeres en edad fértil.

Sueño

Indicar respetar los horarios de sueño recomendando: 8-10 h de sueño nocturno. Los niños suelen necesitar menos rituales que antes. Para el respeto de estos horarios es importante una actitud clara de los padres.

Promover descansos breves al volver de las actividades diarias, en ambiente tranquilo.

Factores facilitadores: actividades deportivas, recreativas y de descarga motora; evitar juegos en la computadora o excesiva TV antes de irse a dormir, desalentar el televisor en la habitación; fomentar la lectura; mantener rutinas y horarios (ver *Anexo*).

Salud bucal

Comienza el recambio de la dentición primaria y aparecen piezas definitivas que, a diferencia de las anteriores, tienen raíz.

A los 6 años se produce la erupción del primer molar definitivo en el maxilar superior e inferior; a partir de allí, se va realizando el recambio total de los dientes de leche.

Recordar la necesidad de un correcto cepillado dental, al menos dos veces al día, siempre antes de acostarse y después de comer golosinas. Evitar dulces o leche antes de irse a dormir. Reemplazar las golosinas azucaradas por las que contienen xilitol como edulcorante. Favorecer la masticación suficiente del bolo alimenticio.

Promover la consulta periódica con el odontólogo, con controles semestrales. Derivar al odontopediatra para su sellado o remineralización.

En los niños con alto riesgo de caries, aportar 1 mg diario de flúor, si no hay fluoración en el agua de consumo (consulte la situación de su zona).

La caries dental tiene una prevalencia de 86% entre los escolares de nuestro país (ver *Anexo*).

El Ingreso escolar

El ingreso a la escuela primaria es el tema central en la consulta del niño de 6 años. La familia vive esta etapa como una crisis vital de crecimiento (ver *Anexo: Problemas del aprendizaje escolar*).

Un niño listo para ingresar a primer grado es capaz de dibujar la figura humana con cabeza, cuerpo, ojos, nariz, boca y miembros; de escribir su nombre, copiar un círculo, un cuadrado, una cruz y un rombo, contar hasta diez y saber los colores básicos.

Es fundamental que cuente con la suficiente independencia afectiva como para poder separarse de los padres y aprender, y que estos lo acompañen de cerca en esta etapa crítica, atentos a la forma en que transcurre esta adaptación.

Recomendar proveer los elementos necesarios para sus tareas y conversar periódicamente con la maestra acerca del desempeño y la actitud hacia el aprendizaje, la conducta y la adaptación a nuevas normas de disciplina, la integración al grupo y la relación con los compañeros. De este modo, se tendrá una medida del funcionamiento global y se podrán detectar disfunciones tempranas. Todas estas medidas serán provechosas para el desempeño general y tendrán un efecto preventivo sobre la difícil situación del fracaso escolar.

Es importante que, ante situaciones relacionadas con la escuela, el pediatra intente comunicarse en forma directa con los docentes sin desvalorizar los señalamientos, teniendo en cuenta que se trata de un referente importante de la familia y que sus opiniones son tomadas como definitivas, y esta puede ser una oportunidad perdida para efectuar intervenciones tempranas.

Recordar que la conducta de los niños se modela sobre la conducta que observan y viven en el seno de su familia nuclear.

Hábitos y conducta. Relaciones familiares y sociales

Recomendar que cada familia provea normas de funcionamiento en el hogar, según sus propios criterios, a las que el niño se irá adaptando gradualmente: horarios de comida, de sueño, de televisión, etc. Además, impartir en la casa normas básicas de convivencia y socialización, y promover el respeto por el derecho de los demás integrantes de la familia.

Enseñar a sancionar las conductas agresivas con los hermanos y a aprender a compartir.

Favorecer las amistades con otros niños, compartiendo juegos en la casa de sus amigos.

Enseñar a respetar las normas de funcionamiento de colegios e instituciones, dando al mismo tiempo elementos para reconocer conductas autoritarias o abusivas.

Sugerir que frente a situaciones conflictivas se discutan los hechos y se resalte el respeto de las ideas, y explicar que el elogio y la aprobación de conductas son muy estimulantes, y que las críticas no deben ser violentas, sino constructivas.

Para los límites se proponen el aislamiento, la explicación razonada y el retiro de actividades o preferencias.

En esta etapa evolutiva, los niños han incorporado e internalizado las normas y pautas de conducta que la familia estimuló.

Los niños comprenden la causalidad lógica de los hechos y son más razonables. La escolaridad es un eje a partir del cual se organizan las rutinas de la vida del niño y sus contactos sociales.

En los discursos acerca de lo permitido y lo prohibido es importante mantener una coherencia.

El desarrollo del niño se puede complicar cuando la vida familiar no logró prepararlo para la vida escolar o cuando la escuela no cubre sus expectativas.

Cuando un niño no puede cumplir normas, se extralimita permanentemente; en tal caso, corresponde preguntarse qué falla. La comunicación ocupa un lugar preponderante; la expresión de los sentimientos, la postura sinceramente comprensiva y la presencia afectiva cumpliendo las funciones parentales, permitirá mejorar esos conflictos y, de esta manera, evitar que el niño se sienta en inferioridad de condiciones y repita el comportamiento que lo deja en desventaja. Ofrecer alternativas atractivas le permitirá tomar decisiones adecuadas.

Recomendar no más de 1 hora de televisión diaria y que los padres ayuden a seleccionar, según los gustos del niño, los programas más convenientes.

Indagar sobre trabajo infantil.

Juego y recreación

A los seis años alterna juegos de gran movimiento con otros sedentarios; puede estar un rato pintando o dibujando, puede aceptar algunas reglas y jugar a las escondidas, a la pelota o correr carreras. Es importante respetar el tiempo para jugar, avisarles que está llegando la hora de comer, para permitirles terminar, y hacer con gusto la nueva tarea.

El gusto por la actividad física y el deporte que manifiesta el niño a esta edad requiere que se le brinden frecuentes oportunidades de esparcimiento en lugares amplios, al aire libre, en

donde pueda disfrutar de juegos de pelota, carreras, bicicletas adecuadas a su tamaño y habilidad, patines, etc.

Recomendar el aprendizaje de la natación y la práctica de juegos de equipo, centrándose en lo recreativo y lúdico, sin estimular el aspecto competitivo de la actividad física. Recomendar el cumplimiento de las normas de seguridad adecuadas durante la realización de actividades físicas y deportivas.

Al entrar en la escolaridad (6 años) –preescolar y escolar– juega con las palabras y los números y es capaz de despegarse de sus padres durante intervalos cada vez mayores.

Si ha estado muy ligado a sus padres, especialmente a su madre, si no ha logrado mínimos actos de libertad, de pensarse a sí mismo, de adueñarse de su cuerpo y de su mente, tendrá problemas en el proceso del aprendizaje.

Los denominados juegos de salón (ludo, dominó, escoba de quince, truco, etc.), le abren nuevos modos de compartir y competir, y también la posibilidad del azar.

El ludo es un viejo juego que, descubierto por los padres y los hijos, les da la oportunidad de combinar el azar con la posibilidad de decidir. Necesita, para la salida, el azar, que el dado le dé el permiso. Luego, el recorrido estará lleno de obstáculos, simbolizando lo que le sucederá en la vida. Estos juegos le permiten tolerar las reglas y perder o ganar. Debe prestar atención, porque de ello dependerá que gane o pierda. Varios juegos, los de barajas entre ellos, tienen las mismas posibilidades: la combinación de suerte y habilidad, y la posibilidad de jugar con los adultos, que le darán el ejemplo de su propia capacidad de jugar a ganar y a perder. Son juegos para ambos sexos.

Las damas y el ajedrez son juegos en los cuales el motor inconsciente parece ser entrar en el mundo de los adultos y competir con ellos. Damas, reyes y reinas son importantes y deben ser vencidos. El éxito aquí depende de la habilidad y no de la suerte.

A veces, parecen grandes y es fácil olvidarse de lo vulnerables que son todavía. Hacen grandes esfuerzos para encontrar la diferencia entre lo que es imaginación y lo que es realidad. Jugar, para ellos parece ser una necesidad, casi una cuestión de vida o muerte. La mayoría ha adquirido ya un buen control de su cuerpo y gozan ejercitando sus habilidades: corren, trepan, bailan, saltan y se hamacan.

Ya cumplidos los siete años y hasta llegar a la pubertad, el cuerpo vuelve a tener un rol fundamental. Los varones, en general, incrementan su gusto por la lucha, las carreras y el fútbol. La mancha y las escondidas son patrimonio de niñas y de varones. Dan permiso para diversos juegos de manos, que tienen su origen en la curiosidad sexual.

El niño de esta edad juega casi siempre con otros niños, aunque a veces prefiere jugar solo dentro de su casa, haciendo construcciones, dibujando, manipulando algún aparato. Observa cuán difícil es hacer dibujos y construcciones y se torna muy crítico de sí mismo. Por ende, no se debe ser exigente con él.

Coleccionar, así como poseer juguetes, ayuda a formar la identidad del niño y cumple varias funciones positivas. Se siente unido al grupo de amigos coleccionistas, se dirimen las rivalidades de manera no violenta, se aprende a intercambiar y a comparar, puede reunir grandes cantidades del objeto que sea y sentirse rico.

Los amigos imaginarios suelen haber sido ya olvidados, pero la fantasía no ha desaparecido.

No es raro que el niño ejercite un sentido del humor que acaba de descubrir, le encantan las adivinanzas, los chistes, los trucos y toda clase de bromas.

Aparece la posibilidad de jugar en equipo; tanto las chicas como los chicos disfrutan con ese sentimiento cálido de sentirse unidos en un equipo manejando su competencia y controlados por las reglas del juego. Pueden ejercitar sus impulsos de rivalidad sin demasiadas fantasías de destrucción (ver Anexo).

Vacunación

Revisar el carnet de vacunación.

Indicar refuerzos de Sabin, triple bacteriana, triple viral.

Controle que el niño haya recibido dos dosis de triple viral después del año de edad o, por lo menos, una dosis de vacuna antisarampionosa o doble viral y otra de triple viral (ver Anexo)

Si los pacientes son mayores de 7 años y no han recibido la vacunación al ingreso escolar se indicarán los refuerzos de Sabin y de triple viral; pero, en reemplazo de la vacuna triple bacteriana (DPT), se debe indicar la vacuna DPT con componente *pertussis* acelular, que se acaba de incorporar al Calendario nacional.

Es importante que hayan completado la serie primaria con DPT (tres dosis). Se reforzará la inmunidad cada diez años con dT.

Contraindique aplicaciones de inmunizaciones anuales por comienzo de clases, campamentos, etc.

Prevención de accidentes

Debido a la intensa actividad que desarrollan los niños a esta edad, la mayoría de los accidentes ocurren fuera de la casa y en los horarios de escuela. Vigilar la seguridad de los lugares de esparcimiento: patios, terrazas, escuelas, clubes. Las actividades recreativas deberán ser vigiladas por un adulto. No dejar nunca solo al niño en piletas de natación u otros espacios de agua, aunque sepa nadar. Impartir enseñanzas sobre las normas de seguridad vial; recuerde que se debe predicar con el ejemplo. Instruir sobre el comportamiento en la calle, en la que deberán circular acompañados por un adulto para el cruce de calles y avenidas. Insistir sobre el uso de cinturón de seguridad y ocupar el asiento trasero del automóvil. Promover el uso de casco cuando se anda en bicicleta o en patines.

Insistir en la casa sobre los cuidados en el manejo de artefactos eléctricos, del fuego, la protección de balcones y aberturas. Evitar, en lo posible, el uso de camas cuchetas. En caso de emplearlas, deben tener siempre baranda protectora (ver Anexo).

Educación sexual

Anticipar que los niños comienzan a demostrar pudor y que se debe evitar mostrar su desnudez. Es importante respetar esas necesidades, inclusive en el consultorio.

Adelantar a los padres la normalidad de la masturbación y la consulta, si fuera compulsiva.

La curiosidad sobre temas relativos a la sexualidad continúa y sus dudas se irán respondiendo a medida que las exprese, mediante un lenguaje adecuado a su entendimiento.

Aconsejar que, para el niño, es importante “sentir” que la familia le brinda, al igual que lo hacen con otros temas, un lugar receptivo a estas inquietudes.

Insistir en la implementación de medidas de protección con respecto a personas extrañas (ver Anexo).

►► PROBLEMAS DETECTADOS Y ESTRATEGIAS

Repasar los problemas detectados y plantear las estrategias para seguir frente a cada uno de ellos.

» CIERRE DE LA VISITA

Preguntar si quedaron dudas y si desean repreguntar algo. Organizar a quién y a dónde deben consultar frente a las interurrencias. Establecer la fecha de la próxima visita en un año, si no existieran complicaciones. En esta etapa, el pediatra podrá valorar la necesidad de visitas más frecuentes cuando aparezcan signos de alarma que sugieran adaptaciones escolares problemáticas. Solicitar traer el cuaderno.

► Niños de 8 y 9 años

El niño que transita los 8-9 años de vida desarrolla, progresivamente, una mayor independencia del grupo familiar, pero la sigue necesitando como base segura para su despegue.

Emocionalmente, deja de vivir inmerso en su familia para dirigirse hacia el afuera ("los otros"), en búsqueda de reconocimiento, normas, sanciones, premios, aceptaciones o rechazos. Tiene una conciencia bastante clara de sí mismo y del rol que ocupa en su familia y la escuela, así como de que los adultos pueden ser falibles y no siempre tienen todas las respuestas.

Hacia el final de esta etapa, el fenómeno más característico es la aparición del llamado "grupo de pares", casi siempre del mismo sexo: su grupo de amigos, del deporte, el barrio, la escuela. Los adultos del afuera (maestros, profesores, ídolos) se van transformando en nuevos modelos de identificación.

Su autoestima deja de depender, exclusivamente, del amor incondicional de su familia y para desarrollarla necesita la valoración que hagan sus maestros y amigos de su habilidad y eficiencia para realizar las tareas requeridas. Ponen el acento en la propia actividad como fuente de logros. Suelen experimentar inseguridad si se sienten o imaginan distintos de los otros. Cualquier diferencia física, por pequeña que sea, puede causarles gran preocupación.

En la escuela consolidan sus habilidades de lectoescritura y aritmética. Desarrollan pensamiento lógico, asocian ideas, extraen conclusiones, resuelven problemas. Afianzan sus intereses a distintos aspectos del mundo exterior: la naturaleza, las artes, la historia y, sobre todo, los juegos y el deporte. Son naturalmente competitivos en sus habilidades y destrezas físicas, trabajo escolar, posesiones, etc. Gradualmente, toleran mejor las frustraciones y la postergación de sus deseos.

La escuela, el club, los campamentos proporcionan nuevos cauces para la expansión de su energía. Disfrutan de la exploración y la aventura.

Se produce una notable maduración de habilidades, que requieren de coordinación neuromotriz. Los niños de esta edad se interesan en actividades, juegos y actos que requieran de dichas habilidades, como bailar, trepar, etc.

Están desarrollando la comprensión de valores morales elevados, como equidad, lealtad, cooperación, tolerancia de los otros, solidaridad y sentido de responsabilidad.

El interés por cuestiones sexuales sigue estando presente, aunque no en primer plano, como lo estuvo en etapas anteriores o lo estará en la adolescencia.

► ENTREVISTA

La capacidad verbal desarrollada a esta edad permite que, al incluir al niño en el interrogatorio, se fomente la motivación y la responsabilidad en el cuidado de su salud.

Es conveniente ofrecer un espacio de bienvenida, que la familia aprovechará para plantear sus dudas y motivos de consulta.

Incluir al niño activamente en la consulta, crea un vínculo importante que le permite al médico convertirse en un referente positivo en las edades posteriores.

Corresponde indagar sobre la posibilidad de trabajo infantil, violencia familiar o barrial y datos indirectos de abuso.

Prestar especial atención a la recepción y el cuidado cuando niños en situación de calle acuden a una institución.

Examen físico y del crecimiento

Es prudente explicarle al niño qué se le va a hacer. Manejar adecuadamente su pudor.

Realizar mediciones antropométricas. Peso. Talla (determinar los percentilos). A partir de los 6 años, por recomendación de SAP, deben usarse las tablas tradicionales hasta 19 años. Relacionar con la altura de los padres.

Relación peso/talla.

Índice de Masa Corporal (IMC): dado el riesgo de establecimiento del sobrepeso y la obesidad a esta edad. Todas las medidas de prevención serán importantes, dadas las dificultades del tratamiento de la obesidad en niños y adolescentes (ver Anexo: Comidas obesogénicas).

Velocidad de crecimiento: determinar los percentilos.

Control de presión arterial: determinar los percentilos.

Explorar la agudeza visual y la audición.

Examen de la columna vertebral (maniobra de Adams).

Exámenes de genitales en presencia de y con la colaboración de los padres.

En el período prepuberal se produce una máxima desaceleración fisiológica del crecimiento; el niño puede crecer, a veces, a menos de 4 cm por año. Recordar que, crecer en el percentilo 10 de velocidad de crecimiento durante 2 años seguidos o más, es anormal.

En las niñas, el comienzo del desarrollo puberal tiene gran variabilidad con respecto a la edad

y notoria influencia genética; es frecuente la aparición del botón mamario a partir de los 8 años, lo cual, generalmente, refleja la indemnidad del eje hipotálamo-hipofisiario-gonadal.

Las niñas con inicio de la pubertad antes de los 8 años deben ser evaluadas, para descartar pubertad precoz que limite la talla definitiva o por estar determinada por una patología.

En el varón, el primer signo de desarrollo puberal está dado por el aumento del tamaño testicular, que pasa a tener mas de 2,5 cm en el diámetro mayor (más de 3 cm³ de volumen) y que siempre, se debe presentar después de los 9 años de edad (ver *Anexos*). La ginecomastia del adolescente habitualmente no supera el estadio 3 de Tanner, ni los 2 años de evolución.

Preste especial atención a la detección de

- ♦ Respiración bucal.
- ♦ Alteraciones de la oclusión dental.
- ♦ Signos de desarrollo puberal antes de los 8 años en las niñas y antes de los 9 años en los niños.
- ♦ Dislalias.
- ♦ Alteraciones de la postura: escoliosis y cifosis (ver *Anexos*).
- ♦ Alteraciones de la marcha.
- ♦ Estrabismo, forias.
- ♦ Caries, mala oclusión.
- ♦ Escoliosis
- ♦ Fimosis.
- ♦ Desarrollo mamario y testicular.
- ♦ Indicadores físicos de negligencia, maltrato o abuso.

Otras evaluaciones de pesquisa

Considerar colesterolemia en niños con factores de riesgo personales o familiares.

Evaluación del desarrollo

Desarrollo y conductas habituales

Motor grueso

- ♦ Mayor destreza y coordinación motora. Realiza deportes y actividades grupales de competencia.

Motor fino

- ♦ Realiza su cuidado personal sin ayuda.
- ♦ Dibuja la figura humana completa y proporcionada. Comienza a tener sentido de perspectiva. Mejora la prolijidad del cuaderno.
- ♦ Usa correctamente los cubiertos.

Lenguaje, escritura

- ◆ Lectoescritura completa.
- ◆ Comienza a tener pensamiento lógico y realiza operaciones abstractas, con lo que progresa en el conocimiento de la matemática. Existe más uniformidad en la inclinación de las letras. Persisten las inversiones ocasionales.

Socio-adaptativo

- ◆ Disfruta las actividades grupales.
- ◆ Cuida sus objetos personales. Asume responsabilidades dentro y fuera del hogar. Respeta al grupo de pares.
- ◆ Busca modelos identificatorios en personas ajenas al grupo familiar. Gran preocupación acerca de la valoración que hacen los demás sobre él mismo.
- ◆ Se ubica geográficamente. Presencia de sentido ético, de ser y de gustos definidos.
- ◆ Le gustan el deporte y los juegos de mesa. Colecciona objetos. Hacia los 9 años inicia proyectos que logra completar.
- ◆ Desarrolla la automotivación.

Considerar la semiología del cuaderno, del dibujo de la figura humana y del dibujo de la familia.

► RECOMENDACIONES PARA LOS PADRES

Alimentación

(Ver Anexos).

Ídem a control de 6 y 7 años.

Prestar atención a la evolución de peso, pues se trata de un período de aumentos excesivos; para ello, habrá que interrogar sobre colaciones, kiosco escolar, comidas fuera de hora y obesogénicas (ver *Anexo sobre calorías y grasas que aportan los alimentos*).

Respetar las cuatro comidas y prestar atención a las colaciones a las horas de actividades sedentarias (TV, PC).

Sueño

(Ver Anexos).

Ídem a control de 6 y 7 años.

Higiene y salud bucal

(Ver Anexos).

Ídem a control de 6 y 7 años.

Entre los 9 y 11 años se reemplazan los molares primarios por los premolares permanentes y, a los 9 años, los caninos inferiores; recién a los 12 años erupciona el segundo molar permanente y, a los 13 años, los caninos superiores. La caries dental tiene una prevalencia de 86% entre los escolares de nuestro país.

Insistir con el cepillado y la consulta odontológica.

Escolaridad

Después de la familia, la escuela es el ámbito más importante en la vida del niño a esta edad.

Haga saber a los padres que el niño valora y relaja su ansiedad y preocupación cuando ve que sus padres y maestros trabajan juntos y se entienden, buscando soluciones a sus problemas.

Indagar si desde la casa o la escuela se promueven u ofrecen otras actividades extracurriculares, como danza, teatro, plástica, música, etc., para enriquecer su sensibilidad, encontrar otros cauces de expresión y, quizás, para tener la oportunidad de desarrollar un talento innato. Todo esto es válido si esta actividad no resulta agobiante.

Muchos de los síntomas físicos o psíquicos que motivan la consulta al pediatra pueden estar generados por problemas en la adaptación a la escuela y al grupo de pares.

Si está descontento con sus compañeros, si ha referido algún hecho de violencia o discriminación hacia sí mismo o hacia alguno de sus compañeros en la escuela, son circunstancias de enorme importancia que pueden interferir con su bienestar. Favorecer que charlen estas preocupaciones con los padres aliviará su angustia y dará pie para que éstos intervengan. Luego los maestros y directivos de la escuela podrán adoptar las medidas necesarias para trabajar estos temas en grupo.

Sugerir a los padres fomentar, activamente en el niño, actitudes solidarias, de tolerancia con los diferentes, no discriminatorias con sus compañeros, de rechazo a la violencia. Observe si desde la escuela se promueven estos valores y se brindan elementos y actividades que los afiancen.

Prestar atención a las observaciones escolares, pues la maestra tiene una visión permanente del niño y se halla en un lugar de privilegio para su evaluación, tanto intelectual como social. Es conveniente que el médico tome contacto directo con el establecimiento educacional (ver *Anexo Problemas de aprendizaje*).

Relaciones familiares y sociales

Promover que cada familia determine, según sus propios criterios, el ejercicio de independencia que va otorgando a los hijos, basados al mismo tiempo en la evaluación de las condiciones del entorno en el cual el niño se desenvuelve.

Informar que los amigos adquieren importancia relevante en este período. Gustan compartir con ellos diversas actividades deportivas, juegos de mesa, lectura de libros o historietas, videos, etc. Concurren a la casa de amigos, amplían su mundo al conocer otras costumbres y modos de relación. Estas relaciones de amistad intensas suelen romperse con facilidad. Los amigos íntimos se recambian y se tejen nuevos lazos y alianzas. Los padres deben saber que estos acontecimientos promueven intensas emociones afectivas en los niños y que, a veces, provoca preocupación y tristeza. Comprenderlos y charlar estos temas con ellos los alivia y fortalece.

Los padres deberán tener en cuenta que el niño debe comprender los motivos de las medidas disciplinarias.

Promueva el ejercicio de responsabilidades con relación a sí mismo, hermanos, pares y tareas de colaboración en el hogar.

Juego y recreación

A esta edad, el juego se caracteriza por la aceptación de reglas y por la preferencia del juego con niños de la misma edad y sexo. Informar a los padres que el juego, el desborde del movimiento y la expresión corporal continúan siendo fundamentales a esta edad.

Reflexionar con los padres acerca de:

Las largas horas que los chicos permanecen sentados en la escuela y del efecto “aquietante” del televisor (desaconsejar más de una o dos horas diarias), el poco espacio en general de departamentos y viviendas, el confort y la facilidad de acceso a los medios de transporte, que imperceptiblemente conducen al niño al sedentarismo. Todos estos factores, que inhiben la expresión del cuerpo y el movimiento, son indeseables para la salud, generadores de síntomas diversos y favorecedores de patologías como la obesidad.

Los padres deben llevar el control del tiempo de juego para alternarlos con los deberes escolares y, de esta forma, irles enseñando a asumir responsabilidades gradualmente.

Tomar conciencia sobre la importancia de generar, en esta etapa de la vida, el deseo y goce por la actividad física y luego el deporte, facilitando el tiempo y los lugares adecuados según las posibilidades de cada familia. Es importante ofrecer la ocasión de jugar y compartir con otros, divertirse, conocer las destrezas propias, respetar reglas, saber competir, canalizar las agresiones y lograr afectos entrañables con los compañeros de equipo. La natación, el andar en bicicleta, el patinar siguen siendo actividades que los niños disfrutan, pero adquieren importancia los juegos grupales (fútbol, básquet, hockey, vóleybol). El fútbol ocupa gran parte del tiempo de juego en los varones.

Observar que las instituciones de práctica y enseñanza que se elijan apunten al divertimento y el gusto por el deporte y no a la búsqueda exclusiva del chico hábil o “estrella” con exigencia y entrenamiento desmedidos. El alerta debe involucrar también las condiciones de higiene y seguridad de los establecimientos a los que concurre y la supervisión idónea de los profesionales entrenados en el trabajo con niños.

Explorar las inclinaciones vocacionales.

Para el niño de esta edad, aunque parezca ya más serio, jugar todavía es una parte vital de su vida. En esta etapa continúan los juegos de equipo, los de mesa y el placer de coleccionar. Juegan con la computadora y les atraen mucho los *hobbies* (ver Anexo).

Prevención de accidentes

Ídem a control de 6 y 7 años (ver Anexo).

El deporte seguro

Debe ser fundamentalmente lúdico y no competitivo. Todo acto de violencia interpersonal intencional o reiterado (aunque no sea un “accidente”) debe ser abordado estrictamente por los padres y autoridades del club. Los pisos (parquet, losa, polvo de ladrillo) y el césped deben ser adecuados y estar en condiciones las canchas. El calzado y la indumentaria deben ser los adecuados; los elementos protectores (casco, protector bucal, rodilleras, etc.) deben estar colocados antes de comenzar la práctica. Respetar los límites individuales sobre la gran variabilidad de la resistencia física en cada niño: el cansancio potencia todos los riesgos y lesiones. Considerar la temperatura ambiente y la exposición al sol. Tener en cuenta la reposición de agua, sales de sodio y potasio.

Recomendar esperar 2-3 h antes de practicar deportes después de un desayuno o un almuerzo normales. Supervisión del número de adultos necesarios, en forma permanente, desde antes de comenzar y hasta después de que termine la actividad deportiva (ver Anexo).

Educación sexual

Estimular la creación en la familia de una atmósfera propicia para que el niño pueda formu-

lar preguntas, pedir información y discutir temas relacionados con el sexo que causen dudas o preocupación. Brindar explicaciones acordes a su capacidad de entendimiento, manteniendo siempre un claro rol paterno. Corresponde adoptar medidas preventivas para evitar la exposición a contenidos eróticos por internet y televisión.

Si bien es poco frecuente el inicio del desarrollo puberal en niñas de 8-9 años, se informará a la niña y a los padres cómo se suceden los cambios puberales, aclarando dudas y brindando información anticipatoria.

Actualmente, es frecuente que los niños se expresen a esta edad con lenguaje y modismos que nos hacen pensar que su información sobre cuestiones sexuales es muy amplia. Esto se debe, sin duda, al amplio acceso que tienen a una información y publicidad vasta sobre el tema, a la que acceden en distintos ámbitos por los que circulan. Sin embargo, son más inseguros de lo que sus bromas aparentan y les cuesta relacionar estos dichos y expresiones con la idea real de una relación amorosa (ver *Anexo Sexualidad-Sexualidades*).

Vacunación

Verificar, en el carnet de vacunación, que el esquema esté completo (ver *Anexos*).

»» PROBLEMAS DETECTADOS Y ESTRATEGIAS

Revisar los problemas detectados y las estrategias por seguir frente a cada uno.

»» CIERRE DE LA VISITA

Preguntar a los padres qué conclusiones sacaron de la entrevista.

Organizar la próxima visita en 1 año o con anterioridad, si se presentan cambios físicos acelerados. En esta etapa, el pediatra podrá valorar la necesidad de visitas más frecuentes cuando aparezcan situaciones que sugieran adaptaciones problemáticas.

Indicar que concurren con el cuaderno a la próxima entrevista. Indicar cómo proceder en caso de enfermedades intercurrentes.